

ДГМУ 2026

Акушерство и гинекология

Акушерство ЛФ by students от 20.06.26

---

#1

**Меры, которые необходимо предпринять при неявке беременной на приём к врачу в назначенный день:**

посещение на дому патронажной акушеркой в ближайшие дни

посещение на дому патронажной акушеркой в ближайшие недели

ждать посещения беременной

пригласить на приём через почту

сообщить в полицию

#2

**Роль смотровых гинекологических кабинетов поликлиник состоит, как правило:**

в диспансеризации гинекологических больных

в обследовании и наблюдении беременных женщин

в проведении периодических медицинских осмотров

в патронаже беременных

в патронаже родильниц

#3

**Первое прикладывание к груди матери здоровых новорожденных проводится обычно:**

сразу после рождения

через 6 часов после рождения

через 8 часов после рождения

через 12 часов после рождения

через 30 мин после рождения

#4

**Основным критерием живорождения является:**

масса плода 1000 г и более

рост плода 35 см и более

наличие сердцебиения

наличие самостоятельного дыхания

срок беременности 28 недель и более

#5

**Перинатальная смертность - это**

смерть плода, начиная с 28-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 12-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 22-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 22-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 3 дней после рождения

смерть плода, начиная с 24-й недели беременности, и смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

#6

**Материнская смертность - это**

смерть женщины во время беременности, в родах или в течение 7 дней после родов

смерть женщины начиная с 22 недели беременности и в родах

смерть женщины во время беременности, родов или в течение 42 дней после окончания беременности

смерть женщины начиная с 22 недели беременности, в родах или в течение 42 дней после окончания беременности

смерть женщины начиная с 37 недели беременности, в родах или в течение 42 дней после окончания беременности

#7

**Минимальный интервал между родами, несоблюдение которого увеличивает материнскую и перинатальную смертность в 2 раза:**

5 лет

4 года

3 года

1 год

6 лет

#8

**Обменная карта выдается беременным в РФ на сроке:**

12 недель

28 недель

22 недели

30 недель

16 недель

#9

**Маточная артерия является ветвью:**

общей подвздошной артерии

наружной подвздошной артерии

внутренней подвздошной артерии

аорты

пупочной артерии

#10

**Большие железы преддверия влагалища расположены:**

в основании малых половых губ

в толще средних отделов больших половых губ

в бороздке между нижними третями малых и больших половых губ

в толще задних отделов больших половых губ

в толще малых половых губ

#11

**Передняя стенка влагалища в ее верхнем отделе граничит:**

с мочеточниками

с дном мочевого пузыря

с шейкой мочевого пузыря

с мочеиспускательным каналом

ни с чем из перечисленного

#12

**Длина маточной трубы у женщины в репродуктивном возрасте, как правило, составляет:**

7-8 см

8-9 см

10-12 см

15-18 см

19-20 см

#13

**Малые половые губы не содержат:**

сальных желез

многослойного ороговевающего эпителия

гладкую мускулатуру

волосяные фолликулы

нервные окончания

#14

**Маточные трубы имеют несколько анатомических отделов, наиболее близкий ко дну матки - это:**

ампулярный

воронка

интерстициальный

фимбрии

истмус

#15

**Части маточных труб в порядке от матки к яичникам:**

интерстициальная, ампулярная, истмическая, воронка

ампулярная, интерстициальная, воронка, истмическая

интерстициальная, истмическая, ампулярная, воронка

истмическая, ампулярная, интерстициальная, воронка

интерстициальная, воронка, истмическая, ампулярная

#16

**В основном кровоснабжение вульвы осуществляется из:**

пудендальной артерии

внутренней геморроидальной артерии

подвздошно-паховой артерии

бедренной артерии

внутренней подчревной артерии

#17

**К внутренним половым органам относятся:**

матка, клитор, яичники, влагалище

яичники, маточные трубы, матка, малые половые губы

влагалище, матка, маточные трубы, яичники, преддверие влагалища

влагалище, матка, маточные трубы, яичники

матка, яичники, влагалище, большие половые губы

#18

**Слизистую оболочку влагалища покрывает эпителий:**

многослойный плоский ороговевающий

цилиндрический

многослойный плоский неороговевающий

сосочковый

ворсинчатый

#19

**Слизистую оболочку маточной трубы покрывает эпителий:**

ороговевающий

цилиндрический

ворсинчатый

сосочковый

многослойный плоский неороговевающий

#20

**Слизистую оболочку цервикального канала эпителий:**

ороговевающий

многослойный плоский неороговевающий

цилиндрический

сосочковый

ворсинчатый

#21

**Задняя стенка влагалища в ее нижней части, как правило, соприкасается:**

с прямой кишкой

с сигмовидной кишкой

с тканями промежности

с бартолиновыми железами

с мочевым пузырем

#22

**К связочному аппарату половых органов не относится**

пудендальная связка

широкая связка

воронко-тазовая связка

круглая связка

собственная связка яичника

#23

**Границей между наружными и внутренними половыми органами обычно является:**

наружный маточный зев

внутренний маточный зев

девственная плева (вход во влагалище)

малые половые губы

ничто из перечисленного

#24

**В процессе менструального цикла происходят:**

овуляция, образование белого тела

образование оранжевого тела

преобладание эстрогенов во II фазе цикла

капацитация

ассимиляция и образование белого тела

#25

**Гипоталамус вырабатывает следующие гормоны:**

гонадотропины

эстрогены

гестагены

рилизинг-факторы

пролактин

#26

**Овуляция- это**

разрыв фолликула и выход яйцеклетки

процесс слияния яйцеклетки со сперматозоидом

отторжение эндометрия

атрезия влагалища

приобретение сперматозоидом двигательной активности

#27

**ФСГ стимулирует:**

рост фолликулов в яичнике

продукцию кортикостероидов

продукцию ТТГ

секреция Пролактина

секрецию прогестерона

#28

**Какое из следующих состояний эндометрия связано с лютеиновой фазой в яичниках:**

пролиферация



отек

атрофия

секреция

менструация

#29

**Какое из следующих состояний эндометрия связано с фолликулиновой фазой:**

атрофия

менструация

секреция

пролиферация

овуляция

#30

**Перечислить все уровни регуляции менструального цикла:**

органы мишени, гипоталамус, гипофиз

органы мишени, яичники, гипофиз, гипоталамус, кора головного мозга

матка, яичники, кора головного мозга, гипофиз, молочные железы

кора головного мозга, гипоталамус, яичники, надпочечники, матка

подкорковые структуры, яичники, гипофиз, гипоталамус

#31

**В 24 недели гестационного возраста длина плода равна:**

30 см

24 см

18 см

12 см

22 см

#32

**В 28 недель гестационного возраста длина плода равна:**

35 см

30 см

24 см

18 см

42 см

#33

**В 32 недели гестационного возраста длина плода равна:**

45 см

43 см

40 см

35 см

30 см

#34

**В 36 недель гестационного возраста длина плода равна:**

48 см

45 см

43 см

40 см

35 см

#35

**В 40 недель беременности в среднем длина плода, как правило, составляет не менее:**

55 см

53 см

50 см

45 см

40 см

#36

**Дифференцировка наружных половых органов у плода происходит в срок гестационного возраста:**

13-20 недель

21-26 недель

27-34 недели

35-40 недель

18 недель

#37

**Становление фетоплацентарной системы, как правило, заканчивается:**

к 16-й неделе беременности

к 20-й неделе беременности

к 24-й неделе беременности

к 28-й неделе беременности

к 32-й неделе беременности

#38

**Оплодотворение яйцеклетки происходит**

в яичнике

в полости матки

в ампулярной части маточной трубы

в брюшной полости

в шейке матки

#39

**Имплантация оплодотворенной яйцеклетки начинается на:**

3 сутки от момента зачатия

4-5 сутки от момента зачатия

6-7 сутки от момента зачатия

на 14-й день менструального цикла

10 сутки после деления зиготы

#40

**Капацитация –это:**

выход зрелой яйцеклетки в брюшную полость

процесс прикрепления зародыша к слизистой оболочке матки

процесс приобретения сперматозоидом фертильной способности

дробление оплодотворенной яйцеклетки

способность сперматозоидов к передвижению по шейному каналу

#41

**Укажите размеры плоскости выхода из малого таза в последовательности- прямой и поперечный:**

9,5см, 11,0см

10,5см, 12,0см

11,5см, 3,0см

12,5см, 13,0см

9 см, 12 см

#42

**Укажите размеры плоскости узкой части малого таза в последовательности- прямой и поперечный:**

11,5см, 10,5см

10,5см, 10,0см

9,5см, 11,0см

12см, 12см

11,5 см, 12,5 см

#43

**Какая связь существует между высотой лоно и истинной конъюгатой?**

чем выше лоно, тем меньше конъюгата

чем выше лоно, тем больше конъюгата

такой зависимости не существует

чем ниже лоно, тем больше истинная конъюгата

чем шире лоно, тем меньше истинная конъюгата

#44

**Вертикальная диагональ ромба Михаэлиса соответствует размеру:**

диагональной конъюгаты

истинной конъюгаты

наружной конъюгаты

прямому размеру плоскости выхода малого таза

прямому размеру широкой части полости малого таза

#45

**Что является границей между большим и малым тазом?**

подвздошная кость

Lin.innominata, мыс

Lin.terminalis, spina ossis ischi superior

пояснично-крестцовое сочленение

ничего из перечисленного

#46

**К какой плоскости малого таза относится размер между spina ossis ischii?**

плоскости входа

плоскости широкой части

плоскости выхода

плоскости узкой части

не относится ни к одной из них

#47

**Какое соединение костного таза является наиболее подвижным в родах?**

лонное сочленение

Articulatio sacroiliaca

Articulatio sacrococcygea

пояснично-крестцовое сочленение

articulatio iliococcygea

#48

**Какую форму имеет поясничный ромб при правильном сложении женщины?**

геометрически правильного ромба

треугольника

неправильного треугольника

прямоугольника

куба

#49

**Нормальные размеры большого таза:**

25-25-31-17 см

25-28-31-20 см

25-28-31-11см

25-28-31-13 см

24-27-32-18 см

#50

**Какой размер малого таза является наиболее важным для прогноза родов?**

косые размеры плоскости входа

прямой размер входа

интерспинальный размер

прямой размер выхода

поперечный размер входа

#51

**Проводная ось таза – это:**

линия, проведенная через середины всех прямых размеров плоскостей таза

кривизна крестца

середина истинной конъюгаты

середина всех поперечных размеров таза

ось проведенная параллельно прямым размерам таза

#52

**Индекс Соловьева у нормостенических женщин равен:**

1,5- 2 см

3-4 см

5-6 см

14-15 см

16-17 см

#53

**Какая плоскость малого таза ограничивается сзади articulatio sacrococcygea?**

входа

широкой части

узкой части

выхода

плоскость узкой и широкой части

#54

**Лонный угол у женщин равен:**

40

50

60-70

90-100

110-120

#55

**В каких эндокринных органах снижается нагрузка во время беременности:**

гипофиз

надпочечники

щитовидная железа

яичники

гипоталамус

#56

**Для какого триместра беременности характерен синдром сдавления нижней полой вены:**

первого

второго

третьего

второго и первого

всю беременность



#57

**Какие из следующих показателей крови являются патологическими для беременности:**

гемоглобин 124г/л

фибриноген 4,9г/л

общий белок 72г/л

тромбоциты  $8 \times 10^9/\text{л}$

СОЭ- 40мм/час

#58

**При нормальной беременности наблюдаются следующие изменения гемодинамики:**

возрастает периферическое сопротивление сосудов

увеличивается объем циркулирующих эритроцитов (ОЦЭ) на 60%

отмечается снижение венозного давления

возрастает объем циркулирующей крови (ОЦК) на 40-50%

снижается ЧСС

#59

**При нормально развивающейся беременности в крови матери:**

увеличивается количество тромбоцитов

повышается гематокрит

снижается содержание фибриногена

возрастает содержание фибриногена

повышается количество эозинофилов

#60

**Во время беременности в яичнике:**

зреют фолликулы

растет яйцеклетка

прекращается выработка прогестерона

происходит овуляция

не происходит овуляция и не зреют фолликулы

#61

**Хорионический гонадотропин вырабатывается:**

в гипофизе

в яичнике

в плаценте

в надпочечниках

в гипоталамусе

#62

**Окситоцин накапливается в течение беременности:**

в гипоталамусе

в яичниках

в задней доле гипофиза

в передней доле гипофиза

в эндометрии

#63

**скриннинг на выявление патологии плода производится в сроке**

11-13,6 недель

6-8 недель

10-11 недель

16-17,6 недель

20-21,6 недели

#64

**Сократительную функцию матки можно оценить с помощью:**

наружной гистерографии

внутренней кардиографии

доплерографии

кольпоцитологии

амниоскопии

#65

**Базальной частотой сердечных сокращений называется:**

ЧСС, сохраняющаяся неизменной в течение 10 мин и более

ЧСС при повышении внутриматочного давления в схватку

число мгновенных колебаний(осцилляции) за 10 мин исследования

сердцебиение плода до начала процесса родов

сердцебиение плода в период сна

#66

**Амниоскопия позволяет оценить:**

количество сосудов в пуповине

доношенность плода

наличие врожденных уродств плода

цвет околоплодных вод

наличие обвития пуповины у плода

#67

**К неинвазивным методам исследования относится**

амниоцентез

кордоцентез

УЗИ

амниотомия

биопсия хориона

#68

**При оценке КТГ плода имеют значение:**

базальная частота сердечных сокращений

наличие и частота ретракций

наличие контракций

амплитуда схватки

наличие дистракций

#69

**Кордоцентез -это:**

взятие пробы крови из маточных артерий беременной

пункция вены пуповины плода

получение околоплодных вод трансвагинальным доступом

получение аспирата ворсин хориона

биопсия кожи плода

#70

**С помощью первого приема наружного акушерского исследования определяют:**

предлежание плода

положение, позицию плода

отношение предлежащей части ко входу в малый таз

уровень стояния дна матки

отношение предлежащей части к плоскостям малого таза

#71

**С помощью второго приема наружного акушерского исследования определяют:**

массу плода

положение, позицию плода

отношение предлежащей части ко входу в малый таз

предлежащую часть

размеры головки плода

#72

**В задачу влагалищного исследования не входит:**

определение целости плодного пузыря

оценка состояния плода

выяснение степени раскрытия шейки матки

определение особенностей вставления головки

оценка размеров таза

#73

**Ультразвуковая оценка II степени зрелости плаценты, как правило, соответствует сроку беременности:**

26-29 недель

более 32 недель

34-37 недель

38-40 недель

21-22 недель

#74

**Малый поперечный размер головки плода равен:**

10 см

10,5 см

8 см

12 см

11 см

#75

**Прямой размер головки плода равен:**

10,5 см

8,5 см

12 см

11,5 см

9,5 см

#76

**Какой шов на головке плода разграничивает лобные и теменные кости:**

лобный

венечный

стреловидный

ламбдовидный

височный

#77

**Большой косой размер головки плода равен:**

9,5 см

11 см

13,5 см

12 см

10 см

#78

**Вертикальный размер головки равен**

13,5 см

11 см

9,5 см

12 см

10 см

#79

**Между какими точками проводится измерение малого косо́го размера:**

от подзатылочной ямки до середины большого родничка

от затылочного бугра до середины большого родничка

от подзатылочной ямки до волосистой части головки

между наиболее отдаленными точками венечного шва

от подзатылочной ямки до границы волосистой части лба

#80

**Что является проводной точкой при переднем виде затылочного предлежания:**

большой родничок

малый родничок

подбородок

середина между большим и малым родничком

затылочный бугор

#81

**Точка фиксации при переднем виде затылочного предлежания:**

малый родничок

затылочный бугор

подзатылочная ямка

большой родничок

переносица

#82

**Что такое большой сегмент головки:**

окружность наименьшего диаметра головки при данном вставлении

окружность наибольшего диаметра головки при данном вставлении

лобная кость

окружность головки

окружность поперечного диаметра головки

#83

**Каким размером прорезывается головка при переднем виде затылочного предлежания:**

малым косым

большим косым

прямым

малым поперечным

вертикальным

#84

**Проводная точка при переднеголовном предлежании:**

малый родничок

лоб

подбородок

большой родничок

венечный шов

#85

**Проводная точка при лобном предлежании:**

большой родничок

малый родничок

лоб

середина лобного шва

подбородок



#86

**Точка фиксации при лицевом предлежании:**

лоб

переносье

подъязычная кость

большой родничок

малый родничок

#87

**При каком виде головного предлежания головка рождается вертикальн размером:**

затылочным, передний вид

затылочным, задний вид

лобном

лицевом

переднеголовном

#88

**Синклитическое вставление головки-это когда:**

стреловидный шов расположен в прямом размере плоскости входа в м/таз

малый родничок находится ниже большого

малый родничок находится выше большого

большой родничок расположен по оси таза

стреловидный шов на одинаковом расстоянии между лоном и мысом

#89

**В каком размере устанавливается на тазовом дне сагиттальный шов при переднем виде затылочного предлежания:**

в прямом, затылком кпереди

в поперечном  
в правом косом  
в левом косом  
в стреловидном

#90

**Диаметр окружности, которой прорезывается головка при переднем виде затылочного предлежания, соответствует:**

среднему косому размеру  
малому косому размеру  
прямому размеру  
большому поперечному  
вертикальному размеру

#91

**За продвижением головки по родовым путям следят с помощью:**

четвёртого приёма Леопольда-Левицкого  
первого Леопольда-Левицкого  
при помощи КТГ  
третьего приёма Леопольда-Левицкого  
второго приёма Леопольда-Левицкого

#92

**Положение плода это:**

отношение спинки плода к сагиттальной плоскости  
отношение спинки плода к фронтальной плоскости  
отношение оси плода к длиннику матки  
взаимоотношение различных частей плода  
отношение спинки плода ко входу в малый таз

#93

**Продольным называется положение, при котором ось плода:**

находится под прямым углом к продольной оси матки

находится под острым углом к оси матки

совпадает с длинником матки

находится под тупым углом к оси матки

совпадает с прямым размером входа в малый таз

#94

**Внутренний поворот головки происходит**

во входе в малый таз

в плоскости выхода из малого таза

при переходе из узкой части полости в широкую

при переходе из широкой в плоскость выхода

в широкой плоскости малого таза

#95

**При первой позиции спинка плода обращена:**

вправо

ко дну матки

влево

ко входу в малый таз

к дну матки

#96

**Под позицией плода понимается:**

отношение спинки плода к боковым стенкам матки

отношение головки плода ко входу в таз

отношение оси плода к длиннику матки

взаимоотношение различных частей плода

отношение головки плода к прямому размеру входа

#97

**Позиция плода при поперечном положении определяется по расположению:**

спинки

головки

мелких частей

тазового конца

конечностей плода

#98

**Вид плода- это отношение:**

спинки к сагитальной плоскости

головки к плоскости входа в малый таз

спинки к передней и задней стенкам матки

оси плода к длиннику матки

спинки плода к боковым стенкам матки

#99

**Наиболее частым предлежанием плода является:**

чистое ягодичное

ягодично-ножное

ножное

головное

неполное ножное

#100

**Предлежание плода- это отношение:**

головки плода ко входу в таз

тазового конца плода ко входу в малый таз

низколежащей крупной части плода ко входу в таз

головки плода ко дну матки

спинки плода к боковым стенкам матки

#101

**Основной критерий окончания первого периода родов характеризуется**

изгнанием плода

началом потуг

полным раскрытием шейки матки

излитием околоплодных вод

раскрытием шейки матки на 13 см

#102

**Началом первого периода родов считают:**

появление регулярных схваток

открытие шейки матки на 1 см

излитие околоплодных вод

вставление головки во вход в малый таз

появление потуг

#103

**При влагалищном исследовании: стреловидный шов находится в левом косом размере, малый родничок- слева у лона. Следует предположить, что у плода**

2 позиция, передний вид

2 позиция, задний вид

1 позиция, передний вид

позиция, задний вид

поперечное положение

#104

**Началом второго периода родов является:**

излитие околоплодных вод

начало потуг

полное раскрытия шейки матки

опускание головки на тазовое дно

вставление головки во входе в малый таз

#105

**Продолжительность второго периода родов у первородящих составляет:**

до 3 ч

до 1ч

до 30 мин

10 мин

до 5ч

#106

**Второй период родов заканчивается:**

отделением последа

рождением плода

полным раскрытием шейки матки

рождением последа

началом потуг

#107

**Название 1 периода родов**

прелиминарный

изгнания

раскрытия

последовый

излития

#108

**Продолжительность 3-го периода родов:**

15 мин

30 мин

1-1,5 ч

1,5-2 ч

3 ч

#109

**Родовая опухоль при переднем виде затылочного предлежания располагается в области:**

среднему косому размеру

правой теменной кости

левой теменной кости

малого родничка

большого родничка

#110

**Сердцебиение плода во втором периоде родов и активной потужной деятельности выслушивается:**

через каждые 15 минут

через каждые 10 минут

через каждые 20 минут

через каждые 5 минут

после каждой потуги

#111

**Какие фазы различают в периоде раскрытия шейки матки:**

латентная и активная

латентная и торпидная

острая и хроническая

латентная и острая

активная и острая

#112

**Физиологическая кровопотеря в родах составляет:**

не более 0,5% от массы тела женщины

2% от массы тела женщины

4-5% от массы тела женщины

10% от массы тела женщины

7% от массы тела женщины

#113

**Для профилактики кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах применяют:**

апилак

окситоцин

баралгин

прогестерон

фенюльс

#114

**При заднем асинклитизме стреловидный шов расположен:**

ближе к лону



ближе к мысу  
строго по оси таз  
к плоскости выхода  
к копчику

#115

**Форма головки новорожденного при заднем виде затылочного предлежания:**

долихоцефалическая  
брахицефалическая  
резко долихоцефалическая  
круглая  
треугольная

#116

**Вставление головки считается нормальным, если оно:**

синклитическое  
асинклитическое  
с небольшим задним асинклитизмом  
с небольшим передним асинклитизмом  
с высоким стоянием сагиттального шва

#117

**Лохии - это:**

послеродовые выделения из матки  
раневой секрет послеродовой матки  
отделение децидуальной оболочки  
инфекционный процесс  
остатки плацентарной ткани

#118

**В послеродовом периоде величина матки уменьшается до размеров небеременной матки через:**

15 недель

3 недель

6 недель

20 недель

сразу после родов

#119

**Молозиво отличается от грудного молока тем, что содержит:**

больше белка

больше жира, молозивные тельца, меньше белка

меньше сахара, больше белка

больше лейкоцитов

больше микроэлементов

#120

**К визуальным признакам полного отделения плаценты в родах не относится**

изменения контуров и смещения дна матки

удлинение наружного отрезка пуповины

отсутствия втягивания пуповины при глубоком вдохе роженицы

прекращения пульсации пуповины

усиление кровотечения из половых путей

#121

**Признак Шредера заключается в**

удлинение наружного отрезка пуповины

появление позывов на потуги

изменение формы и высоты стояния матки

втягивание пуповины при натуживании

втягивание пуповины при глубоком вдохе

#122

**Как проверяется признак Кюстнера -Чукалова**

удлинение наружного отрезка пуповины

появление позывов на потуги

надавливание ребром ладони над лоном

втягивание пуповины при натуживании

втягивание пуповины при глубоком вдохе

#123

**Какой признак не входит в шкалу Апгар**

частота с/б

дыхание

рост

цвет кожных покровов

рефлексы

#124

**Когда оценивается новорожденный по шкале Апгар**

через 10 минут после рождения

на 2 сутки после родов

на 1 и 5 минуте после рождения

на 5 и 10 минуте после рождения

на 10 и 15 минуте после рождения

#125

**Что является показанием к эпизиотомии?**

крупный плод

отказ роженицы тужиться

угроза разрыва промежности

возраст роженицы старше 35 лет

дискоординированная родовая деятельность

#126

**Для рвоты беременных лёгкой степени наиболее характерно:**

частота рвоты от 3 до 5 раз в сутки

частота пульса 90-100 уд. в мин

наличие ацетона в моче

рвота до 10 раз в сутки

снижение диуреза

#127

**Для лечения беременной с ранним токсикозом не применяют**

прегинор

витамины гр. В

эуфиллин

р-ра Рингера-Локка

антагонисты дофамина

#128

**У беременной с тяжелым течением раннего токсикоза проявлением интоксикации организма является все перечисленное, кроме:**

учащения пульса до 100-120 в мин

повышения t-ы тела выше 38°C

повышение АД

наличия ацетона в моче

резкой потери в весе

#129

**Для какой степени тяжести рвоты беременных характерно отсутствие ацетона в моче:**

легкой

средней

тяжелой

неукротимой

пограничной

#130

**К клиническим признакам рвоты беременных не относится**

тошноты

рвоты

прибавки в весе

похудания

гипотонии

#131

**К редко встречающимся формам раннего токсикоза не относится:**

тетания беременных

слюнотечение

остеомалация беременных

острая жёлтая атрофия печени

бронхиальная астма

#132

**В качестве препаратов 1-й линии для лечения рвоты беременных легкой и умеренной степени рекомендуется**

вит В1

пиридоксин

вит С

эссенуиале

церукал

#133

**В качестве препаратов 2-й линии для лечения рвоты беременных легкой и умеренной степени рекомендуются**

пиридоксин

вит В1

вит С

эссенуиале

церукал

#134

**В качестве препаратов 3-й линии для лечения рвоты беременных умеренной и тяжелой степени рекомендуются**

вит В1

кортикостероиды системного действия

вит С

эссенуиале

церукал

#135

**Показанием для прерывания беременности при раннем токсикозе является всё, кроме:**

непрекращающейся рвоты

выраженной тахикардии

нарушений функций нервной системы

потеря массы тела

угрозы прерывания беременности

#136

**Для легкой ПЭ характерна протеинурия**

до 0,3 г/л

6-7 г/л

1-5 г/л

вообще не характерна

до 10 г/л

#137

**HELLP-синдром – это**

синдром задержки роста плода

осложнение раннего токсикоза

осложнение беременности

генетическое заболевание плода

послеродовое кровотечение

#138

**Для тяжелой ПЭ характерна протеинурия**

до 0,3 г/л

1-3 г/л

5-6 г/л

вообще не характерна

1-2 г/л

#139

**К клиническим признакам эклампсии не относится:**

тошнота, рвота

тонические судороги

клонические судороги

сокращения мимических мышц

потеря сознания

#140

**Препаратом 1 линии антигипертензивной терапии при ПЭ является**

атенолол

магния сульфат

метилдопа

коринфар

дибазол

#141

**Препаратом 2 линии антигипертензивной терапии при ПЭ является**

атенолол

магния сульфат

нифедипин

коринфар

дибазол

#142

**Препаратом 1 линии профилактики и лечения судорог при тяжелой ПЭ и эклампсии является**

диазепам

габапентин

магния сульфат

фенозепам



фенибут

#143

**Наиболее грозным симптомом преэклампсии является:**

альбуминурия более 5 г/л

значительная прибавка массы тела

боли в эпигастрии

тошнота, рвота

энцефалопатия

#144

**Признаком эклампсии является:**

гипертензия

альбуминурия

повышенная возбудимость

судороги и кома

головная боль

#145

**Абсолютным показанием к операции кесарево сечение при ПЭ являются:**

преждевременное созревание плаценты (по данным УЗИ)

запоздалое созревание плаценты (по данным УЗИ)

диссоциированное созревание плаценты

прогрессирующая отслойка плаценты при незрелой ш/м

ПРПО

#146

**Базовая терапия ПЭ не включает:**

родоразрешение

антигипертензивную терапию

антикоагулянты

противосудорожную терапию магния сульфатом

седацию

#147

**При тяжелой ПЭ характерно повышение АД**

150/90 мм рт ст

130/90 мм рт ст

170/100 мм рт ст

155/90 мм рт ст

140/90 мм рт ст

#148

**С какого срока беременности начинает повышаться АД при ПЭ**

с начала беременности

с 15 недель беременности

с 20 недель беременности

с 10 недель беременности

с 35 недель беременности

#149

**С целью профилактики ПЭ с 12 недель беременности назначается**

препараты кальция

вит Д3

ацетилсалициловая кислота

дибазол

магния сульфат

#150

**Наиболее выраженный фактор риска невынашивания беременности среди перечисленных:**

возраст

наличие в анамнезе 3 самопроизвольных выкидышей в сроке 8-14 недель

курение

тазовое предлежание плода

рост женщины

#151

**Наиболее частой причиной самопроизвольного аборта в ранние сроки является:**

несовместимость по резус-фактору

поднятие тяжести, травма

хромосомные аномалии

инфекции

истмико-цервикальная недостаточность

#152

**Недостаток какого вещества в легких плода наблюдается при СДР плода?**

сурфактант

окиситоцин

токоферол

серотонин

инсулин

#153

**Новорожденные с СДР более подвержены развитию:**

желтухи

ателектаза легкого

омфалита

пузырчатки

мочекислого инфаркта

#154

**Созреванию легких плода способствует:**

введение глюкокортикоидов

в/в капельное вливание раствора магния сульфата

в/м введение спазмолитика

использование мифепристона

введение антагонистов кальция

#155

**Шкала Сильвермана применяется для оценки новорожденного:**

доношенного

недоношенного

переношенного

зрелого

при асфиксии новорожденного

#156

**Диагноз преждевременных родов может быть поставлен при рождении плода:**

массой 3000 г, длиной 50 см

массой 2800 г, длиной 48 см

массой 2600 г, длиной 47 см

массой 400 г, длиной 20 см

массой 2300 г, длиной 44 см

#157

**Что из приведенного не является причиной преждевременных родов:**

многоводие

многоплодие

токсикоз первой половины беременности в анамнезе

истмико-цервикальная недостаточность

инфекции

#158

**Преждевременные роды – это роды в сроке:**

22 – 27 недель

28 – 33 недели

22-36,6 недель

22 – 35 недель

38 – 40 недель

#159

**Начавшиеся преждевременные роды характеризуются:**

регулярными схватками

ноющими болями внизу живота

отсутствием структурных изменений шейки матки

отхождением слизистой пробки

вставлением предлежащей части

#160

**Для лечения угрожающих преждевременных родов не применяют:**

атозибан

бета-миметики

окситоцин

трактоцил

лечебно-охранительный режим

#161

**Наименьшая масса тела жизнеспособного плода составляет:**

500 г

600 г

800 г

1000 г

900 г

#162

**В нашей стране за критерий жизнеспособности плода (новорожденного) принимается срок беременности от:**

20 недель

22 недели

26 недель

28 недель

24 недели

#163

**Очень ранние преждевременные роды – это роды:**

до 28 недель

28-30 недель 6 дней

31-33 недели 6 дней

34-36 недель 6 дней

22-26 недель

#164

**Поздние преждевременные роды - это роды:**

до 28 недель

28-30 недель 6 дней

31-33 недели 6 дней

34-36 недель 6 дней

36-37 недель

#165

**Особенности ведения преждевременных родов**

обязательно проводится обезболивание промедолом

роды принимает только врач, а не акушерка

не проводится защита промежности

рекомендуется вакуум-экстракция плода

нельзя производить амниотомию

#166

**Какие лабораторные исследования показаны при ПРПО:**

С-реактивный белок каждые 3 дня

развернутый анализ крови каждый день

влагищный мазок каждый день

электролиты крови каждые три дня

биохимический анализ крови

#167

**Рекомендуется пролонгировать беременность при ПРПО в сроки:**

24-34 недели

20-24 недели

34-36 недель

37-38 недель

22-28 недель

#168

**Проводится ли антибиотикотерапия при ПРПО в недоношенном сроке беременности:**

проводится всегда

не проводится

проводится при наличии гипертермии

проводится только при ПРПО в 22-24 недели

проводится только при повышенном СРБ

#169

**Профилактику дистресс-синдрома плода при ПРПО проводят в сроки:**

24-34 недели

20-24 недели

34-36 недель

37-38 недель

26-28 недель

#170

**С целью антибиотикопрофилактики при ПРПО рекомендуют:**

эритромицин

амоксиклав

рифампицин

амоксициллин

доксикалин

#171

**Что является противопоказанием к консервативной тактике при преждевременных родах**

умеренная ПЭ

преждевременный разрыв плодных оболочек

раскрытие ш/м более 4-5 см



срок гестации 30 недель

наличие рубца на матке

#172

**Какие из перечисленных признаков указывают на наличие многоводия?**

увеличение окружности живота

низкое стояние дна матки

слабость или отсутствие сердцебиения плода

снижение массы тела беременной

уменьшение объема околоплодных вод

#173

**Какие осложнения могут возникнуть у матери при многоводии?**

преждевременные роды

перенашивание беременности

преждевременное созревание плаценты

снижение уровня гемоглобина до нормальных значений

повышение артериального давления

#174

**Какие методы исследования используются для подтверждения многоводия?**

УЗИ с оценкой индекса амниотической жидкости (ИАЖ)

доплерометрия

кордоцентез

кардиотокография (КТГ)

общий анализ крови

#175

**Какие особенности характерны для ведения родов при многоводии?**

### ранняя амниотомия

исследование амниотической жидкости

обязательна перидуральная анестезия

эпизиотомия во 2 периоде

ручное отделение последа в 3 периоде родов

#176

**Основным клиническим симптомом многоплодной беременности является:**

выявление при наружном акушерском исследовании трех и более крупных частей плода

несоответствие величины матки сроку беременности

указания беременной на частые шевеления плода

пролабирование плодного пузыря

симптом флюктуации

#177

**При аускультации беременной с многоплодной беременностью характерно:**

наличие двух точек с ясным выслушиванием сердечных тонов плодов

между точками ясного звука нет зоны приглушения

частота сердечных сокращений в разных точках не отличается

тахикардия обоих плодов

приглушенное сердцебиение обоих плодов

#178

**Наиболее точным применяемым методом диагностики многоплодия является:**

УЗ - исследование

наружное акушерское исследование

фоноэлектрокардиография

амниоскопия

МРТ

#179

**Течение беременности при многоплодии наиболее часто осложняется:**

недонашиванием беременности

рождением крупных плодов

перенашиванием

ожирением

гипотонией

#180

**Наиболее частое осложнение в родах при многоплодии:**

слабость родовой деятельности

запоздалое отхождение околоплодных вод

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

разрыв матки

гипоксия плодов

#181

**После рождения первого плода при продольном положении второго показано:**

влагалищное исследование

амниотомия

выжидательная тактика самостоятельного рождения плода

внутривенное введение окситоцина

кесарево сечение

#182

**Показанием к кесареву сечению при многоплодной беременности является**

тазовое предлежание 2 плода

узкий таз 1 ст

три и более плодов

желание беременной

головное предлежание 1 плода

#183

**Ревматизм поражает преимущественно:**

митральный клапан сердца

аортальный клапан

трехстворчатый клапан

клапан легочной артерии

нет правильного ответа

#184

**Ревматизм — это заболевание:**

инфекционно-аллергическое

паразитарное

гормональное

наследственное

генетическое

#185

**Какое осложнение наиболее характерно для гестационного сахарного диабета?**

ПРПО

маловодие

крупный плод

стремительные роды

ранний токсикоз

#186

**Вирусная инфекция попадает к плоду:**

параплацентарно

трансплацентарно

восходящим путем

воздушно-капельным путем

половым путем

#187

**К вирусному инфицированию плод наиболее чувствителен:**

в ранние сроки беременности

в середине беременности

в последние сроки беременности

перед родами

в родах

#188

**Эмбриопатии при внутриутробном инфицировании наиболее характерны для инфекций:**

микотических

бактериальных

вирусных

паразитарных

вызванных гемолитическим стрептококком

#189

**Заражение токсоплазмозом происходит:**

через мясные продукты питания (без их термической обработки)

контактным путем

воздушно-капельным путем

гематогенным путем

половым путем

#190

**Урогенитальный хламидиоз - это инфекция, вызванная:**

внутриклеточным паразитом

вирусом

бактерией

простейшими

атропонозы

#191

**Урогенитальный хламидиоз у беременной не способствует:**

преждевременному прерыванию беременности

развитию послеродовой инфекции

развитию пневмонии у новорожденного

развитию слабости родовой деятельности

развитию конъюнктивита новорожденного

#192

**Сократительная функция матки при слабости родовой деятельности обычно характеризуется:**

последовательной сменой ретракции и дистракции волокон миометрия

сохранением ритма и снижением амплитуды сокращения матки

увеличением частоты схваток

повышением внутриматочного давления

нерегулярными схватками

#193

**При слабости родовой деятельности имеет место:**

повышение базального тонуса матки

уменьшение венозного наполнения матки

резкая болезненность схваток

отсутствие или замедление динамики раскрытия шейки матки

нерегулярные сокращения матки

#194

**Замедление скорости раскрытия шейки матки в родах может свидетельствовать:**

об угрозе разрыва матки

о преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты

дистоции шейки матки

о разрыве шейки матки

патологическом прелиминаре

#195

**Для стимуляции родовой деятельности применяют:**

окситоцин

пабал

аскорбиновая кислота

глюкозо-новокаиновая смесь

дексаметазон

#196

**При дискоординации сократительной деятельности матки внутриамниотическое давление по сравнению с нормой:**

повышено

понижено

не изменено

в зависимости от толщины стенки матки

понижается при дистоции шейки матки

#197

**Наиболее частое осложнение при дискоординации родовой деятельности это:**

выпадение петель пуповины

преждевременное излитие околоплодных вод

эмболия околоплодными водами

интранатальная гипоксия плода

хориоамнионит

#198

**Для лечения слабости родовой деятельности применяют:**

токолитики

бета-миметики

спазмолитики

утеротоники

простагландины

#199

**При быстрых родах у первородящей продолжительность родов составляет:**

6-8 ч

1-2 ч

8-10ч

4-6ч

2-3

#200

**При стремительных родах у повторнородящей продолжительность родов составляет:**

6-8 ч

4-6 ч



8-10ч

1-2ч

не имеет значение

#201

**Клинически узкий таз – это:**

остановка родов из-за утомления роженицы

упорная слабость родовой деятельности

дискоординация, переходящая в слабость схваток и потуг

патологический прелиминарный период

несоответствие размеров головки плода и таза роженицы

#202

**Размер истинной конъюгаты 8,5 см позволяет отнести таз к степени сужения:**

I

II

III

IV

к клинически узкому

#203

**В прогнозе родов при анатомически узком тазе наибольшее значение имеет**

высота дна матки

окружность живота

многоводие

размеры головки плода

маловодие

#204

**3 степень клинически узкого таза (абсолютное несоответствие) характеризуется следующими признаками:**

мочеиспускание не нарушено

**признак Вастена положительный**

имеет место конфигурация головки

имеет место поступательное движение головки

биомеханизм родов не нарушен

#205

**Потуги при головке, прижатой ко входу в малый таз, отошедших водах, при неполном раскрытии зева, как правило свидетельствуют:**

об окончании первого периода родов

о начавшемся разрыве матки

**о клинически узком тазе**

об ущемлении передней губы шейки матки

об отслойке плаценты

#206

**Узким тазом 4 степени считается таз при истинной конъюгате:**

**5 см**

11 см

13 см

10 см

9 см

#207

**Для какого вида узкого таза характерны следующие размеры: 28-28-32-18**

Общеравномерно-суженный таз

Плоскорахитический таз

Простой плоский таз

Поперечно-суженный таз

Нормальные размеры таза

#208

**Какие размеры соответствуют общеравномерно-суженному тазу?**

25-28-32-21

23-25-29-18

22-25-27-21

28-28-32-18

25-28-31-18

#209

**Какие размеры соответствуют поперечно-суженному тазу?**

25-28-32-21

22-25-27-21

23-25-29-18

28-28-32-18

25-28-31-18

#210

**Какие размеры соответствуют простому плоскому тазу?**

25-28-32-21

25-28-31-18

22-25-27-21

28-28-32-18

23-25-29-18

#211

**В каком случае при тазовом предлежании показаны роды через естественные родовые пути?**

крупные размеры плода

анатомическое сужение таза

разгибание головки плода

ножное предлежание у первородящей

ягодичное предлежание при средних размерах плода

#212

**При тазовом предлежании в 1 периоде родов, при выпадении петель пуповины, рекомендуется:**

извлечение плода за тазовый конец

кесарево сечение

наблюдение

родостимуляция

назначение спазмолитиков

#213

**При чисто ягодичном предлежании во 2 периоде родов оказывают пособие:**

по Вастену

Цовьянова 1

Цовьянова 2

извлечение плода за паховый сгиб

кесарево сечение

#214

**Среди видов тазового предлежания наиболее благоприятным является:**

чисто ягодичное

смешанное ягодичное

неполное ножное

полное ножное  
ягодично-ножное

#215

**Пособие Цовьянова-1 при чисто ягодичном предлежании не способствует:**

сохранению членорасположения плода  
профилактике разгибания головки  
профилактике спазма шейки матки  
профилактике запрокидывания ручки  
повороту на головку

#216

**При ножном предлежании используется акушерское пособие Цовьянова 2, которое способствует:**

переводу ножного предлежания в чисто ягодичное  
переводу ножного предлежания в смешанное ягодично-ножное  
переводу ножного предлежания в поперечное положение плода  
переводу в головное предлежание  
способствует сгибанию последующей головки

#217

**Тазовое предлежание, при котором ножки плода согнуты в тазобедренных и разогнуты в коленных суставах относятся к:**

смешанному ягодичному предлежанию  
чисто ягодичному  
неполному ножному  
полному ножному  
поперечному положению

#218

**При тазовом предлежании для рождения последующей головки применяют приём Морисо-Левре, который способствует:**

разгибанию головки

внутреннему повороту головки

сгибанию головки

наружному повороту головки

повороту плечиков

#219

**При тазовом предлежании наружный поворот плода с целью перевода в головное предлежание производят в сроки:**

40 недель

36-37 недель

28-30 недель

24-26 недель

38-39 недель

#220

**При тазовом предлежании и наличии рубца на матке рекомендуется:**

ведение родов через естественные родовые пути под контролем УЗИ

выключение II периода родов путём извлечения плода за тазовый конец

ведение родов с применением пособия по Цовьянову во II периоде

операция кесарево сечение

извлечение плода за ножку

#221

**Пособие по Цовьянову-1 применяют при следующем предлежании плода:**

чистом ягодичном

смешанном ягодичном

смешанном ягодичном и неполном ножном

неполном ножном

полным ножном

#222

**Смешанное ягодичное предлежание плода характеризуется следующим:**

ножки разогнуты в тазобедренных и коленных суставах

ножки разогнуты в голеностопных суставах

вместе с ягодицами предлежит одна или обе ножки плода

ножки согнуты в тазобедренных, разогнуты в коленных суставах

ножки разогнуты и в тазобедренных и в коленных суставах

#223

**Какие из перечисленных операций производятся при поперечном положении плода в родах:**

амниотомия, поворот плода на ножку при раскрытии 8 см

амниотомия, поворот плода на головку

наружный поворот плода

кесарево сечение

поворот плода на ножку при полном раскрытии

#224

**Какое осложнение встречается чаще всего при поперечном положении плода:**

преждевременное или раннее отхождение вод, выпадение ручки

слабость родовой деятельности

кровотечение

разрыв матки

образование мочеполовых свищей

#225

**Причины поперечного положения плода:**

большая масса плода

преэклампсия

возраст старше 35 лет

длинная пуповина

аномалия развития матки

#226

**При наружном осмотре для поперечного положения плода характерно**

поперечно-овальная форма матки, предлежащая часть отсутствует

матка удлинненно-овальной формы, определяется предлежащая часть

при наружном исследовании нельзя получить информацию о положении плода

матка в форме песочных часов

матка шаровидной формы

#227

**При каком положении плода при влагалищном исследовании прощупывают подмышечную впадину, иногда локти или кисть:**

при продольном

при поперечном

при тазовом предлежании

при 1-й позиции

при заднем виде

#228

**При влагалищном исследовании определяется: головка плода прижата ко входу в малый таз. пальпируется носик, ротик и подбородок. О каком предлежании идет речь**

затылочное



лицевое

лобное

переднеголовное

задний вид затылочного

#229

**Точки фиксации при переднеголовном предлежании:**

надпереносье, затылочный бугор

верхняя челюсть, затылочный бугор

подзатылочная ямка

граница волосистой части головы, подзатылочная ямка

область подъязычной кости

#230

**Проводная точка при лицевом предлежании:**

большой родничок

малый родничок

переносица

подбородок

граница волосистой части головы

#231

**Точки фиксации при лобном предлежании:**

верхняя челюсть, затылочный бугор

надпереносье, затылочный бугор

подзатылочная ямка

граница волосистой части лба, подзатылочная ямка

большой родничок

#232

**В каком виде протекают роды при разгибательных предлежаниях:**

задний вид

передний вид

задний вид, переходящий в передний

передний вид, переходящий в задний

возможен любой вариант

#233

**При влагалищном исследовании для переднеголового предлежания характерно:**

большой родничок ниже малого, является проводной точкой

определяются лобный шов, надбровные дуги, надпереносье, переносица (проводная точка)

пальпируется ротик, носик плода, скуловые кости, глазницы, проводной точкой является подбородок

малый родничок ближе большого, является проводной точкой

определяется малый родничок и сагитальный шов

#234

**В биомеханизме родов при лицевом предлежании плода точкой фиксации, как правило, является**

подъязычная кость

верхняя челюсть

подзатылочная ямка

затылочный бугор

волосистая часть лба

#235

**Головка плода в родах при переднеголовном предлежании прорезывается окружностью, соответствующей:**

малому косому размеру

среднему косому размеру  
большому косому размеру  
прямому размеру  
вертикальному размеру

#236

**При лобном предлежании родоразрешение проводят:**

путем наложения вакуум-экстрактора на головку плода  
с помощью атипичных акушерских щипцов  
путем кесарева сечения  
с применением родостимуляции окситоцином или простагландинами  
с применением рассечения шейки матки и промежности

#237

**На какие сутки развивается перитонит после кесарева сечения**

на 1-2 сутки  
на 2-3 сутки  
на 4-5 сутки  
на 6-7 сутки  
на 10 сутки

#238

**Послеродовые заболевания протекают более тяжело, если они обусловлены:**

чистой культурой стафилококка  
чистой культурой стрептококка  
микробными ассоциациями  
вирусами  
кишечной палочкой

#239

**Акушерский перитонит чаще всего возникает после:**

родов своевременных

преждевременных родов

кесарева сечения

позднего выкидыша

запоздалых родов

#240

**Наиболее частый путь распространения инфекции при мастите:**

лимфогенный

гематогенный

галактогенный

восходящий

воздушно-капельный

#241

**Для клиники перитонита после кесарева сечения не характерно**

выраженной интоксикации

пареза кишечника

доскообразного живота- дефанса брюшной стенки

задержки газов

вздутия живота

#242

**Наиболее частая форма послеродового воспалительного процесса:**

мастит

тромбофлебит

эндометрит

параметрит

сепсис

#243

**Клиническая картина послеродового эндометрита не включает:**

симптомы интоксикации

субинволюцию матки

мягкую консистенцию и болезненность матки при пальпации

характер лохий, не соответствующий дню послеродового периода

гиперемия в области лобка

#244

**Показанием к экстирпации матки в послеродовом периоде не является**

тазовый тромбофлебит

перитонит

сепсис без метастазов

септический шок

сепсис с метастазами

#245

**Наиболее частая причина плацентарной недостаточности:**

тяжелые формы ПЭ

анемия беременных

многоводие

предлежание плаценты

многоплодие

#246

**Причиной задержки внутриутробного развития плода может быть:**

плацентарная недостаточность

резус отрицательная кровь у матери

истмико-цервикальная недостаточность

угроза разрыва матки

аномалии развития матки

#247

**Причиной ранней ЗРП не может являться:**

хромосомные аномалии плода

генетические синдромы

тазовое предлежание плода

привычное невынашивание

рубец на матке

#248

**II ст. ЗВРП характеризуется отставанием плода на:**

1 нед

2 нед

4 нед

более 6 нед

#249

**Основной причиной острой плацентарной недостаточности является:**

угрожающие преждевременные роды

профессиональные вредности

накопления в крови плода недоокисленных продуктов обмена

отслойка плаценты

генитальный инфантилизм

#250

**Признаками гипоксии плода на КТГ являются:**

мгновенные акцелерации

реактивный тип КТГ

брадикардия

ЧСС 150 в мин

ЧСС 130 уд в 1 мин

#251

**Основной клинический признак острой гипоксии плода в родах:**

урежение сердцебиения плода до 100 ударов в минуту

наличие мекония в водах

глухость тонов сердца плода

учащение сердцебиения плода до 150 уд в 1 мин

отсутствие шевеления плода

#252

**Лечение хронической гипоксии плода во время беременности должно быть направлено на:**

введение окситоцина

восстановление ОЦК крови

восстановление гормонального фона

антианемическое лечение

нормализацию плацентарного кровообращения и профилактику метаболического ацидоза

#253

**Изучение биофизического профиля плода не предполагает:**

регистрация беременной количества шевелений плода

оценку дыхательных движений плода

измерение окружности живота и высоты дна матки

оценку результатов нестрессового тест

оценку количества околоплодных вод

#254

**К легкой степени асфиксии относится оценка по шкале Апгар:**

8 баллов

7 - 6 баллов

5 баллов

4 и менее балла

9-10 баллов

#255

**При гипоксии плода ацидоз плазмы крови:**

нарастает

снижается

существенно не изменяется

изменяется так же, как в эритроцитах

медленно снижается

#256

**Для диагностики внутриутробной задержки роста плода наиболее информативны данные:**

о содержании прогестерона

о содержании плацентарного лактогена

о содержании трофобластического гамма-глобулина

результаты ультразвуковой фетометрии

данные амниоскопии

#257

**О гипоксии плода свидетельствует:**



брадикардия плода

гипотония матери

появление тошноты у матери

зуд беременных

артериальная гипертензия

#258

**Для гипоксии плода не характерно:**

тахикардия плода до 160 в мин. и более

брадикардия до 100 в мин. и менее

нарушение сердечного ритма, глухость тонов

базальный ритм 140 уд в 1 мин

ареактивный НСТ

#259

**Клиническая картина при предлежании плаценты характеризуется:**

уменьшением интенсивности шевеления плода

повторяемостью кровотечения из половых путей

высоким процентом продольных положений плода

высоким процентом запоздалых родов

тахикардией у плода

#260

**Основными причинами развития предлежания плаценты являются:**

субсерозная миома матки

истмико-цервикальная недостаточность

генерализованный ангиоспазм

дистрофические изменения слизистой оболочки матки

ожирение

#261

**Для преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты наиболее характерно**

артериальная гипертония

брадикардия

гипертонус матки

тахикардия

тошнота

#262

**Если прогрессирующая преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты развилась во время беременности, следует произвести:**

родовозбуждение путем введения окситоцина

раннюю амниотомию

острый токолиз

операцию кесарева сечения

введение бета миметиков

#263

**Если преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты произошла в первом периоде родов, следует:**

произвести операцию кесарева сечения

наложить акушерские щипцы

применить вакуум-экстракцию плода

применить антифибринолитики и токолитики

произвести амниотомию

#264

**Для диагностики предлежания плаценты наиболее целесообразно применить:**

радиоизотопную сцинтиграфию

тепловидение

ультразвуковое сканирование

влагалищное исследование

амниоскопию

#265

**Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является:**

болезненность матки при пальпации

наружного кровотечения может и не быть

имеются признаки внутрибрюшного кровотечения

всегда наружное

пропитывание стенки матки

#266

**При консервативном ведении родов у рожениц с преждевременной непрогрессирующей отслойкой плаценты можно использовать**

спазмолитики

промедол

окситоцин

пабал

мифепристон

#267

**При полном предлежании плаценты при отсутствии кровотечения операция Кесарева сечения обычно производится в плановом порядке:**

с началом родовой деятельности

при сроке 36 недель

при сроке 38-39 недель

в 37 недель

в 35 недель

#268

**При консервативном ведении родов при неполном предлежании плаценты применяют:**

кожно-головные щипцы по Уилт - Иванову

поворот на ножку с последующей экстракцией плода

метрейринтер

рассечение шейки матки

раннюю амниотомию

#269

**При ведении беременной с полным предлежанием плаценты нельзя:**

проводить КТГ плода

проводить доплерометрию сосудов плода

производить влагалищное исследование вне операционной

выслушивать сердечные тоны плода

проводить биохимический скриннинг

#270

**Величина патологической кровопотери в родах:**

0,30 % от массы тела

0,40 % от массы тела

0,45 % от массы тела

0,50 % от массы тела

0,6 % от массы тела

#271

**При преждевременной отслойке плаценты, расположенной на передней стенке матки, характерно:**

локальная болезненность

схваткообразные боли в крестце и пояснице

отеки нижних конечностей

отеки передней брюшной стенки

рвота

#272

**Наиболее частой причиной преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты является:**

ранний токсикоз беременных

тяжелая преэклампсия

гестационный сахарный диабет

пороки развития матки

анемия

#273

**При прогрессирующей преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты роженице показано:**

родостимуляция окситоцином

родостимуляция простагландинами

введение метилэргометрина капельно внутривенно

абдоминальное родоразрешение в неотложном порядке

амниотомия

#274

**При плотном прикреплении плаценты ворсины хориона проникают в глубь стенки матки:**

в базальный слой слизистой оболочки

в миометрий

в компактный слой слизистой оболочки  
в спонгиозный слой слизистой оболочки  
в функциональный слой эндометрия

#275

**Для истинного приращения плаценты характерно врастание ворсин хориона:**

в базальный слой слизистой оболочки  
в миометрий  
в компактный слой слизистой оболочки  
в спонгиозный слой слизистой оболочки  
в функциональный слой эндометрия

#276

**При истинном приращении нормально расположенной плаценты показано:**

ручное отделение плаценты  
выскабливание послеродовой матки  
надвлагалищная ампутация матки  
перевязка подвздошных сосудов  
ввести окситоцин

#277

**Выберите определение состояния атонии матки:**

несовершенный тонус матки  
потеря сократительной способности матки  
недостаточная сократительная активность  
непрекращающиеся потуги  
выраженный гипертонус матки

#278

**Гипотония матки чаще развивается в:**

первые два часа после родов

первые сутки после родов

первую неделю после родов

прелиминарном периоде

через 2-недели после родов

#279

**Показанием к ручному отделению плаценты является:**

кровотечение из половых путей при отсутствии признаков отделения плаценты

предлежание плаценты

низкая плацентация

болевым симптом

резкое повышение АД

#280

**Укажите какая кровопотеря является показанием для ручного отделения последа:**

до 100мл

до 200 мл

500 мл и более

300 мл

умеренные кровянистые выделения

#281

**Что происходит в сосудистой системе при первой стадии геморрагического шока:**

вазодилатация

вазоконстрикция

резкое падение АД

резкое падение ЦВД

пропитывание кровью стенки матки

#282

**Укажите, как меняется уровень тромбоцитов и фибриногена в фазу гиперкоагуляции при ДВС-синдроме:**

снижается

повышается

остаются без изменений

незначительно снижаются

тромбоциты снижаются, а фибриноген повышается

#283

**Что характерно для второй фазы геморрагического шока:**

декомпенсация

повышается уровень фибриногена

укорачивается время свертывания

АД норма

ЦВД норма

#284

**Укажите правильный диагноз при: кровопотере 1000 мл., АД 90/70 мм рт.ст., пульс 120 уд/мин., бледность., олигурия:**

геморрагический шок I ст

геморрагический шок II ст

геморрагический шок III ст

ДВС синдром

шоковая матка

#285



**Объём операции у родильниц с ДВС-синдромом:**

высокая ампутация матки

надвлагалищная ампутация матки

экстирпация матки

перевязка сосудов

ампутация шейки матки

#286

**Какому препарату отдадите предпочтение при ДВС-синдроме:**

раствору альбумина

сухой плазме

свежезаготовленной плазме

физиологический раствор

полиглюкину

#287

**Укажите на наиболее частую причину коагулопатии:**

операция наложения акушерских щипцов

преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты

разрыв матки

преждевременные роды

резус-конфликт

#288

**Шоковый индекс – это соотношение:**

пульс/ систолическое АД

пульс/диастолическое АД

систолическое АД/ пульс

вес/систолическое давление

вес/диастолическое давление

#289

**Укажите шоковый индекс, соответствующий наиболее тяжелому состоянию больной:**

0,5

1,5

1,0

0,8

0,1

#290

**Укажите, что не характерно для геморрагического шока:**

тахикардия

гипотония

цианоз

гипертермия

тахикардия

#291

**Разрыв шейки матки 2 ст:**

по длине равен 2 см

более 2 см, но не доходит до свода влагалища

доходит до свода влагалища

переходит на свод влагалища

отрыв шейки матки от сводов

#292

**Показанием к эпизиотомии не является:**

ригидная промежность при тазовом предлежании

сужение влагалища

угроза разрыва промежности

острая гипоксия плода

наложение акушерских щипцов

#293

**Причина разрыва матки во время беременности:**

крупный плод

многоводие

несостоятельность рубца на матке

анатомически узкий таз

преэклампсия

#294

**Что должен делать врач сразу же при диагнозе "угрожающий разрыв матки"?**

усилить родовую деятельность

оставить на прежнем уровне

снять родовую деятельность и произвести операцию Кесарево сечение

наложить акушерские щипцы

назначить гипотензивную терапию

#295

**Как изменяется родовая деятельность при совершившемся разрыве матки?**

усиливается

прекращается

характер не меняется

становится дискоординированной

становится судорожной

#296

**Что нужно предпринять при разрыве матки?**

вести роды через естественные родовые пути

произвести поворот плода на ножку

немедленное чревосечение

назначить антагонисты окситоцина

наложить акушерские щипцы

#297

**Почему после родоразрешающих влагалищных операций производят ручное обследование полости матки?**

чтобы удалить остатки плаценты

убедиться в целости матки

предупредить кровотечение

усилить сокращения матки

удалить оболочки и плаценту

#298

**Кольпорексия- это:**

разрыв промежности

разрыв переднего свода влагалища

разрыв влагалища

разрыв лонного сочленения

разрыв шейки матки

#299

**В каком случае лучше воздержаться от применения анальгезирующих препаратов в родах:**

дискоординации родовой деятельности

преждевременных родов

преэклампсии

наличии рубца на матке

артериальной гипертензии

#300

**Первым этапом зашивания разрыва промежности III степени является:**

восстановление слизистой влагалища

наложение швов на мышцы промежности

восстановление сфинктера прямой кишки

зашивание разрыва стенки прямой кишки

ушивание кожи промежности

#301

**Клиническая картина при угрожающем разрыве матки характеризуется наличием:**

похолоданием конечностей

повышением температуры тела

гипотонии матки

отека половых губ

матки в форме «песочных часов»

#302

**Разрыв шейки матки III степени (с одной или двух сторон) характеризуется тем, что он:**

более 2 см, но не достигает до свода влагалища

достигает до свода влагалища

сливается с разрывом матки

происходит отрыв шейки матки от сводов

сопровождается разрывом сфинктера прямой кишки

#303

**Тактика ведения родильницы при быстро нарастающей гематоме наружных половых органов должна быть следующей:**

применяют давящую повязку

внутрь - витамин с, хлорид кальция

проводят антианемическое лечение

применяют утеротоники

вскрытие гематомы и ушивание разорвавшегося сосуда

#304

**Какой из показателей не входит в классификацию разрыва матки:**

по времени

по клинике

по локализации

по силе воздействия

по течению

#305

**Кесарево сечение- это операция:**

плодоразрушающая

подготавливающая родовые пути

родоразрешающая

сохраняющая беременность

на шейке матки

#306

**Где производится разрез на матке при кесаревом сечении по Гусакову?**

у дна матки продольно

у дна матки поперечно

в нижнем сегменте продольно

в нижнем сегменте поперечно

в теле матки

#307

**Классическое кесарево сечение- это когда:**

разрез делают на нижнем сегменте матки поперечно

разрез делают на теле матки поперечно

разрез делают на теле матки продольно

разрез делают в дне матки

разрез делают продольно в нижнем сегменте

#308

**К ближайшим осложнениям кесарева сечения относятся:**

аденомиоз

перитонит

спаечная болезнь

несостоятельный рубец

гипотоническое кровотечение из матки

#309

**К отдалённым осложнениям кесарева сечения относится**

мастит

эндометриоз

эктропион

ожирение

миома матки

#310

**В настоящее время разрезом выбора на матке является**

корпоральный продольный

продольный в нижнем сегменте матки

поперечный в нижнем сегменте матки

в дне матки

истмико- корпоральный

#311

**Какой метод обезболивания наиболее часто применяется при кесаревом сечении?**

интубационный

спинальный блок

масочный наркоз

внутривенный наркоз

инфильтрационный

#312

**Какие условия из нижеперечисленных необходимы для производства кесарева сечения?**

беременность 20 недель

живой и жизнеспособный плод

стабильная гемодинамика

возраст беременной старше 20 лет

головное предлежание плода

#313

**Какова средняя кровопотеря при кесаревом сечении?**

150-200 мл

300-400 мл

700-1000 мл

1200-1500 мл

2000мл



#314

**Через какое время разрешается вставать больным после планового кесарева сечения?**

через 5-6 часов

через 5-6 дней

через 2 дня

через 1 час

через 24 часа

#315

**Для сокращения матки после извлечения плода рекомендуется ввести внутривенно?**

кордиамин

промедол

окситоцин

цефтриаксон

транексам

#316

**Через сколько дней подлежит выписке родильница после кесарева сечения?**

через 7 дней

через 2 недели

через 3 недели

через 5 дней

через 3 дня

#317

**Что является наиболее тяжёлым осложнением послеоперационного периода после кесарева сечения?**

гипертермия

парез кишечника

перитонит

субинволюция матки

метрит

#318

**Плановое кесарево сечение показано при:**

слабости родовых сил

тазовом предлежании крупного плода

выпадении пуповины

преждевременной отслойке плаценты

желание беременной

#319

**Метод родоразрешения, если в предыдущих родах у женщины был разрыв промежности 3 степени:**

роды через естественные родовые пути

кесарево сечение

наложение акушерских щипцов

вакуум экстракция плода

зависит от массы плода

#320

**Наиболее характерный момент в технике классической операции (корпоральное) кесарева сечения**

вскрытие полости матки продольным разрезом в теле матки

вскрытие полости матки продольным разрезом в нижнем сегменте

вскрытие полости матки поперечным разрезом в нижнем сегменте с ушиванием раны по Ельцову-Стрелкову

вскрытие полости матки поперечным разрезом в нижнем сегменте с ушиванием раны по Гусакову – Занченко

вскрытие полости матки поперечным разрезом в дне матки

#321

**Показания для корпорального кесарева сечения**

маловодие

многоводие

крупный плод

многоплодие

варикозное расширение вен в области нижнего сегмента

#322

**К абсолютным показаниям к операции кесарева сечения не относится**

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты при раскрытии 5 см

поперечное положение второго плода при двойне

полное предлежание плаценты

угрожающий разрыв матки

рак шейки матки

#323

**Показанием к плановому кесареву сечению является**

умеренная ПЭ

узкий таз 1 степени

крупные размеры плода

многоплодие

несостоятельный рубец на матке

#324

**Антибиотикопрофилактика гнойно-септических осложнений при проведении операции кесарева сечения может производиться:**

за 1 час до операции

в первые сутки после операции

за 1 день до операции

в течение 3-х дней после операции

не проводится

#325

**С целью профилактики тромбоэмболических осложнений при проведении показан:**

компрессионный трикотаж во время операции и после

введение антиагрегантов за час до операции

постельный режим первые 24 часа после операции

введение Транексама во время операции

введение Окситоцина после извлечения плода

#326

**Наиболее часто единственным признаком начинающегося разрыва матки по рубцу может быть**

ухудшение состояния плода

гипертонус стенок матки

слабость родовой деятельности

повышение артериального давления роженицы

артериальная гипотензия

#327

**Что не является показанием к наложению акушерских щипцов?**

узкий таз 1 степени сужения

гипоксия плода

слабость родовой деятельности

## ПОНРП

мерцательная аритмия у роженицы

#328

**Что является показанием для наложения акушерских щипцов?**

угрожающий разрыв матки

клинически узкий таз

тяжёлая степень преэклампсии

крупный плод

маловодие

#329

**Что является противопоказанием для наложения акушерских щипцов?**

слабость родовой деятельности

гипоксия плода

эклампсия в родах

угрожающий разрыв матки

головное предлежание плода

#330

**Какое из условий необходимо для наложения акушерских щипцов?**

открытие 8 см

отсутствие околоплодного пузыря

головка большим сегментом во входе в малый таз

гидроцефалия плода

наличие плодного пузыря

#331

**Какая ложка вводится первой и какой рукой при наложении полостных акушерских щипцов?**

левая, левой рукой

правая, правой рукой

левая, правой рукой

правая, левой рукой

не имеет значение

#332

**Сколько пальцев необходимо ввести во влагалище при наложении акушерских щипцов?**

один

два

три

четыре

пять

#333

**Наиболее часто акушеры используют щипцы:**

правосудия

Киллянда

Симпсона - Феноменова

Негеля

Боделока

#334

**Как надо проводить тракции акушерскими щипцами?**

непрерывно

прерывисто, имитируя потуги

маятникообразно

попеременно- то влево, то вправо

вращательными движениями

#335

**Наиболее распространённый метод обезболивания при наложении акушерских щипцов:**

внутривенный наркоз

масочный закисно-кислородный наркоз

пудендальная анестезия

перидуральная анестезия

местная анестезия

#336

**Назовите противопоказания к операции наложения акушерских щипцов:**

тяжёлый поздний гестоз

недоношенный плод

тяжёлая гипоксия плода

эндометрит в родах

высокая температура

#337

**Применяемые виды операции наложения щипцов в настоящее время:**

выходные

полостные и высокие

высокие, полостные и выходные

никакие

компрессионные

#338

**В каком случае показана краниотомия?**

совершившийся разрыв матки, мертвый плод

запущенное поперечное положение, мертвый плод

центральное предлежание плаценты, мертвый плод

лобное вставление, мертвый плод

тазовое предлежание плода, мертвый плод

#339

**После плодоразрушающей операции ручное обследование матки:**

показано

не показано

возможен кюретаж

необходимо в случае предполагаемого осложнения

только при наличии кровотечения

#340

**При наложении выходных акушерских щипцов ложки должны лечь на головку плода:**

в правом косом размере

в поперечном размере

в прямом размере

в вертикальном размере

в левом косом размере

#341

**Наложение акушерских щипцов противопоказано:**

при внутриутробном инфицировании плода

при эндометрите у матери

при острой гипоксии плода

при эклампсии

при разрыве матки

#342



**Наиболее часто при родоразрешении акушерскими щипцами возникает разрыв:**

шейки матки

влагалища

матки

мочевого пузыря

лонного сочленения

#343

**Показания для наложения вакуум-экстрактора**

вторичная слабость потуг

несвоевременное излитие околоплодных вод

клинически узкий таз

дискоординация родовой деятельности

мертвый плод

#344

**Показания для наложения вакуум-экстрактора плода**

дистресс плода во втором периоде родов

тазовое предлежание плода

бурная родовая деятельность

дискоординация родовой деятельности

мертвый плод

#345

**Первое тройное правило при наложении акушерских щипцов**

правая ложка, правая рука, правая сторона таза; левая ложка, левая рука, левая сторона таза

правая ложка, правая рука, левая сторона таза; левая ложка, левая рука, правая сторона таза

правая нога, правая рука, правая сторона таза; левая нога, левая рука, левая сторона таза

левая ложка, правая рука, правая сторона таза; правая ложка, левая рука, левая сторона таза

#346

**Наиболее частым осложнением со стороны плода при наложении вакуум-экстрактора является**

формирование кефалогематомы

внутриутробная пневмония

парез Эрба-Дюшена

перелом ключицы

внутричерепное кровоизлияние

#347

**Показанием к краниотомии является:**

отказ роженицы тужиться

угрожающий разрыв матки

гидроцефалия плода

гипоксия плода

несоответствие размеров таза и головки

#348

**Операция краниотомии не включает:**

экзентерацию

перфорацию головки

эксцеребрацию

краниоклазию

наркоз

#349

**Первый этап краниотомии:**

эксцеребрация

перфорация головки

краниоклазия

эвисцерация

экзентерация

#350

**В набор инструментов для проведения плодоразрушающих операций не входят:**

влагалищные зеркала

щипцы Симпсона- Феноменова

ножницы Феноменова

пулевые щипцы

краниокласт Брауна и перфоратор Бло

#351

**Какой медицинский документ выдается на руки женщинам только при беременности?**

родовой сертификат

обменная карта

медицинский страховой полис

пенсионное удостоверение

справка о прохождении узких специалистов

#352

**В настоящее время, согласно приказу 747Н, обязательными являются УЗИ скрининги при беременности на сроках:**

14-16,6 недель

18-20,6 неделя

34-35,6 недели

37-38,6 недель

11-13,6недель

#353

**Что включает понятие нормальная беременность по данным УЗИ согласно клин.рекомендациям?**

визуализация в полости матки одного эмбриона/плода

наличие сердцебиения плода

отсутствие пороков развития плода

наличие желтого тела в одном из яичников

нормальные показатели доплерометрии

#354

**За весь период наблюдения за течением нормальной беременности приемы беременной проводятся следующими специалистами:**

врачом акушер-гинекологом не менее 5 раз

врачом терапевтом не менее 2 раз

врачом стоматологом не менее 2 раз

врачом стоматологом 1 раз

врачом акушер-гинекологом не менее 10 раз

#355

**Обязательными в 1 триместре являются анализы:**

о/а крови

анализ крови на гомоцистеин

кровь на ТТГ

наследственные тромбофилии

кровь на группу и резус фактор

#356

**В отделение наблюдения родильного дома, госпитализируются:**

беременные с гипертермией, связанной с ОРВИ

роженицы без паспорта

родильницы на 15-е сутки после родов с признаками мастита

беременные и роженицы, являющиеся носителями HbSAg

роженицы с признаками бартолинита

#357

**Исследование на RW, ВИЧ и гепатиты у беременной проводится**

во 2 триместре

непосредственно перед родами при поступлении в Роддом

не проводится

в 1 триместре

в 3 триместре

#358

**Общий анализ мочи при нормально протекающей беременности назначается в сроки:**

в 1 триместре

в 3 триместре

во 2 триместре

ежемесячно

за неделю до родов

#359

**В биохимический скрининг беременных, входят:**

анализ крови на свертываемость

определение уровня АФП в крови

определение уровня ХГЧ в крови

определение в крови сыв. Fe

определение в крови уровня эстрогенов и прогестерона

#360

**При выявлении высокого риска пороков развития плода по данным скрининга 1-го или 2-го триместра рекомендовано направить беременную пациентку на проведение инвазивной пренатальной диагностики**

биопсия хориона при сроке 10-14 недель беременности

амниоцентез при сроке беременности > 15 недель

амниоскопия в 15-16 недель

доплерометрия 20-25 недель

кордоцентез в 18-20 недель

#361

**Когда рекомендовано женщине провести анализ крови на ТТГ?**

при планировании беременности

в 1 триместре

во 2 триместре

в 3 триместре

не проводится без особых показаний

#362

**Перинатальная смертность включает**

смерть новорожденного в течение первых 10 дней после рождения

смерть плода, начиная с 12-й недели беременности

смерть новорожденного в течение первых 7 дней после рождения

смерть плода, начиная с 22-й недели беременности

смерть плода в родах

#363

**Материнская смертность включает**

смерть женщины во время беременности

смерть женщины начиная с 22 недели беременности

смерть женщины во время родов

смерть женщины начиная в течение 42 дней после окончания беременности

смерть женщины начиная с 37 недели беременности и в родах

#364

**К наружным половым органам у женщин относятся:**

влагалище

лобок

малые и большие половые губы

шейка матки

преддверие влагалища

#365

**К внутренним половым органам относятся:**

матка

яичники

бартолиниевые железы

клитор

маточные трубы

#366

**Передняя стенка влагалища граничит:**

с мочеточниками

с дном мочевого пузыря

с шейкой мочевого пузыря

с мочеиспускательным каналом

с прямой кишкой

#367

**Задняя стенка влагалища граничит:**

с мочеточниками

дугласовым пространством

с шейкой мочевого пузыря

с прямой кишкой

с сигмовидной кишкой

#368

**Маточные трубы имеют несколько анатомических отделов - это:**

ампула

воронка

интерстициальный

цервикс

нижний сегмент

#369

**К связочному аппарату яичников относятся**

пудендальная связка

крестцово-маточная

воронко-тазовая связка

круглая связка

собственная связка яичника

#370

**Малые половые губы содержат:**

сальные железы

бартолиновы железы

гладкую мускулатуру



волосяные фолликулы

нервные окончания

#371

**Большие половые губы:**

содержат сальные железы

не содержат бартолиновые железы

содержат гладкую мускулатуру

не содержат волосяные фолликулы

содержат бартолиновые железы

#372

**Части маточных труб:**

интерстициальная

ампулярная

воронка

влагалищная

овариальная

#373

**К связочному аппарату матки относятся**

связка Трейтца

серповидная связка

широкая связка

венечная связка

круглая связка

#374

**К глубоким мышцам диафрагмы таза относятся:**

наружный сфинктер заднего прохода

лобково-копчиковая мышца

мышца, поднимающая задний проход

подвздошно-копчиковая мышца

копчиковая мышца

#375

**К поверхностным мышцам мочеполовой диафрагмы относятся**

седалищно пещеристая мышца

луковично губчатая

мышца, поднимающая задний проход

поверхностная поперечная мышца промежности

подвздошно-копчиковая мышца

#376

**Какие утверждения в отношении клитора верны?**

представляет собой соединительнотканную перепонку

расположен в своде влагалища

непарный орган

расположен под наружным отверстием мочеиспускательного канала

образуется двумя пещеристыми телами

#377

**Какие утверждения в отношении малых половых губ верны?**

покрыты волосами

в толще малых половых губ расположены Батролиновы железы

верхние ножки образуют крайнюю плоть клитора

сзади заканчиваются в заднем своде влагалища

нижние ножки образуют уздечку клитора

#378

**Какие утверждения в отношении матки верны?**

непарный мышечный орган

тело матки имеет грушевидную форму

это парный мышечный орган

полость на разрезе имеет треугольную форму

полость в разрезе имеет овальную форму

#379

**Какие утверждения в отношении маточной трубы верны?**

парный трубчатый орган

труба имеет воронку

самый узкий просвет в перешейке трубы

самый узкий просвет в истмической части трубы

длина трубы 5-6 см

#380

**Какие утверждения в отношении яичника верны?**

парный орган

верхний край обращен к маточной трубе

это непарный орган

это женская половая железа

нижний край обращен к маточной трубе

#381

**Откуда отходят яичниковые артерии:**

от маточной артерии

лобково-копчиковой артерии

от аорты

внутренней подвздошной артерии

от почечной артерии

#382

**Уровни регуляции менструального цикла:**

гипофиз

яичники

матка

мозжечок

надпочечники

#383

**К гонадотропным гормонам гипофиза относятся**

лютеинизирующего(ЛГ)

фолликулостимулирующего(ФСГ)

соматотропный гормон

Люлиберин

адренокортикотропный гормон

#384

**Яичниковый цикл включает следующие фазы:**

фолликулярная

лютеиновая

пролиферация

секреторная

гипофизарная

#385

**Под влиянием эстрогенов в эндометрии происходят процессы:**

секреция

овуляция

регенерация

пролиферация

десквамация

#386

**Биологические эффекты андрогенов:**

атрофия эндо- и миометрия

атрофия железистой ткани молочных желез

подавление секреции гонадотропинов гипофиза

стимуляция секреции гонадотропинов гипофиза

подавление секреции сальных желез

#387

**Под влиянием ГнРГ происходит выработка следующих гормонов в передней доле гипофиза:**

лютеинизирующего(ЛГ)

фолликулостимулирующего(ФСГ)

тестостерона

андрогенов

тиреотропного

#388

**К 5 уровню регуляции менструального цикла относятся**

гипофиз

гипоталамус

амигдалоидные ядра

лимбическая система

надпочечник

#389

**Биологическая роль ЛГ заключается в:**

стимуляция овуляции

формирование желтого тела

стимуляция синтеза прогестерона в клетках желтого тела

рост и созревание фолликулов

синтез эстрогенов в тека клетках

#390

**Основными фракциями эстрогенов являются:**

дегидроэпиандростенон

эстрон

эстрадиол

эстриол

эстрон

#391

**В гипофизе синтезируются следующие гормоны:**

кортизол

эстрадиол

ЛГ

ФСГ

прогестерон

#392

**Что относится к уровням регуляции менструального цикла?**

гипофиз

гипоталамус

надпочечника

щитовидная железа

кора головного мозга

#393

**Какие утверждения верны?**

при рождении в яичниках девочки находится примерно 2 млн. примордиальных фолликулов

ко времени менархе в яичниках содержится 200-450 тыс. примордиальных фолликулов

при рождении в яичниках девочки находится примерно 2000-3000 примордиальных фолликулов

на протяжении одного менструального цикла развивается, как правило, 5-6 фолликулов с яйцеклеткой внутри

в течение жизни могут овулировать около 400-500 фолликулов

#394

**Фазы менструального цикла:**

секреция

децелерация

васкуляризация

обратное развитие

десквамация

#395

**ФСГ стимулирует:**

рост фолликулов в яичнике

продукцию кортикостероидов

продукцию ТТГ

секрецию Пролактина

секрецию эстрогенов

#396

**Стадии созревания фолликула:**

примордиальная

преантральная

преимплантационная

преовуляторная

заключительная

#397

**Процесс оплодотворения, управляемый гипоталамусом, проходит несколько этапов**

имплантация

плацентация

пенетрация

кортикальная реакция

образование зиготы

#398

**Во внутриутробном развитии различают периоды:**

эмбриональный

фетальный

плацентарный

имплантационный

преантральный

#399

**Стадии развития эмбриона:**

фистула

фетус



зигота

морула

бластула

#400

**Из каких отделов состоит децидуальная оболочка?**

decidua phetalis

decidua sacralis

decidua basalis

decidua capsularis

decidua parietalis

#401

**Какие утверждения в отношении плаценты верны?**

плацента состоит из 20-30 долек

структурной единицей плаценты является ацинус

структурной единицей плаценты является котиледон

плацента состоит из 40-60 долек

материнский и плодовой кровоток не сообщаются друг с другом

#402

**Какие утверждения в отношении пуповины верны?**

в пуповине проходят 3 сосуда (1 артерия и 2 вены)

при доношенной беременности длина пуповины составляет 90-95 см

при доношенной беременности длина пуповины составляет 50—55 см

сосуды пуповины погружены в соединительную студенистую ткань (вартонов студень)

в пуповине проходят 3 сосуда ( 2 артерии и 1 вена)

#403

**Какие утверждения в отношении околоплодных вод верны?**

в течение 3 дней происходит полный обмен околоплодных вод

при доношенной беременности количество вод равно 5 л

это биологически активная окружающая плод среда

в течение 3 часов происходит полный обмен околоплодных вод

в образовании околоплодных вод принимают участие трофобласт, ворсины хориона, эпителий амниона, почки и легкие плода

#404

**Плацента продуцирует гормоны:**

плацентарный лактоген

ХГЧ

прогестерон

тестостерон

АКТГ

#405

**Какие зародышевые листки образуются в процессе развития зародыша?**

эктодерма

энтодерма

мезодерма

мезенхима

морула

#406

**Связь материнского организма и плода осуществляется через:**

плаценту

барорецепторы стенки матки

водные оболочки плода

децидуальную оболочку матки

пуповину

#407

**Какие названия носит структурно-функциональная единица плаценты:**

ацинус

синус

котиледон

плацентон

нефрон

#408

**Какие сосуды проходят в пуповине?**

3 вены

1 артерия

2 артерии

1 вена

2 вены

#409

**Критические периоды развития плода**

имплантация, соответствующая 7—8-му дню эмбриогенеза

плацентация приходится на 3—8-ю неделю эмбриогенеза и совпадает с этапом формирования зачатков органов

3-6 день- овуляторный период

28-32 недели- фетальный период

активного органогенеза: 15—20-я нед. беременности (усиленный рост головного мозга) и 20—24-я нед. (формирование основных функциональных систем организма)

#410

**Во внутриутробном развитии человека условно выделяют следующие периоды:**

период плацентации

преимплантационный

эмбриональный

фетальный

зиготный

#411

**Сердечно-сосудистая система эмбриона- какие из утверждений верны?**

на 7—8-й неделе ЧСС эмбриона равно 140 уд/мин

отверстие в межжелудочковой перегородке закрывается после рождения ребенка

первые сокращения сердца и движения крови обнаруживаются уже в начале 4-й недели его развития

на 7—8-й неделе ЧСС эмбриона равно 177 уд/мин

малый круг кровообращения у плода не функционирует

#412

**Гемопозз плода- какие из утверждений верны?**

начиная с 3 месяца костный мозг принимает участие в эритропоэзе

после 7 месяцев беременности селезенка становится основным местом эритропоэза

в периферической крови плода эритроциты появляются на 7—8-й неделе

фетальный гемоглобин отличается повышенной способностью поглощать кислород

в периферической крови плода эритроциты появляются на 12-й неделе

#413

**Нервная система плода- какие из утверждений верны?**

на 4-й неделе беременности имеются 5 первичных мозговых пузыря

критический период созревания коры большого мозга приходится на 5-6- ю неделю беременности

критический период созревания коры большого мозга приходится на 12—16-ю неделю беременности

на 4-й неделе беременности имеются 3 первичных мозговых пузыря — передний, средний и задний мозг

критический период созревания коры большого мозга приходится на 9-10-ю неделю беременности

#414

**В плоскости входа в малый таз различают размеры:**

прямой

диагональная конъюгата

наружная конъюгата

поперечный

правый и левый косые

#415

**Полость малого таза имеет следующие отделы:**

плоскость узкой части

плоскость Годжи

плоскость прямого размера входа в малый таз

плоскость широкой части

плоскость поперечного размера входа в малый таз

#416

**Величину истинной (акушерской) конъюгаты можно вычислить, измерив:**

индекс Перля

длину бедренных костей

ширину лонного сочленения

диагональную конъюгату

наружную конъюгату

#417

**Расстояние от верхнего края лонного сочленения до надкрестцовой ямки называется**

диаметр Боделока

Lin.innominata

диагональная конъюгата

Conjugata externa

наружная конъюгата

#418

**Что является границей между большим и малым тазом?**

ребень подвздошной кости

Lin.innominata

мыс

spina ossis ischi superior

крестцово-копчиковое сочленение

#419

**Что является границей плоскости выхода из малого таза?**

ребень подвздошной кости

нижний край симфиза

седалищные бугры

spina ossis ischi superior

крестцово-копчиковое сочленение

#420

**Диагональная конъюгата- это расстояние между:**

верхним краем лонного сочленения

мысом крестца

нижним краем лонного сочленения

верхушкой копчика

крестцово-копчиковым сочленением

#421

**Что является границей плоскости широкой части полости таза?**

ребень подвздошной кости

середина симфиза

место сочленения 2 и 3 крестцовых позвонков

spina ossis ischi

крестцово-копчиковое сочленение

#422

**Что является границей плоскости узкой части полости таза?**

ребень подвздошной кости

нижний край симфиза

крестцово-копчиковое сочленение

ребень подвздошной кости

мыс крестца

#423

**Отличие женского таза от мужского предполагает**

лонный угол у мужчин больше

кости женского таза тоньше и легче

полость таза у мужчин имеет форму усеченного конуса, а у женщин цилиндрическая

плоскость входа в малый таз у мужчин имеет форму карточного сердца, а у женщин овальная

крестец у женщин длиннее и уже

#424

**Отличие женского таза от мужского предполагает**

седалищные кости у мужчин расположены параллельно

женский таз ниже и шире

крестцовая впадина в женском тазе более выражена

лонный угол у женщин 90-100 градусов, а мужчин 70-75

крестец у женщин длиннее и уже

#425

**Укажите правильные размеры большого таза**

distantia spinarum 25–26 см

distantia cristarum 28–29 см

distantia trochanterica 25-26 см

conjugata externa 20–21 см

distantia cristarum 30-31см

#426

**Во время беременности в сердечно-сосудистой системе матери происходят следующие изменения:**

тахикардия

смещение электрической оси сердца

увеличение ОЦК

брадикардия

повышение АД

#427

**Какие изменения при аускультации сердца происходят у беременных?**

тахикардия

акцент 1 тона на верхушке сердца

систолический шум на верхушке сердца



брадикардия

ослабление 1 тона на верхушке сердца

#428

**Какие изменения происходят в свертывающей системе беременных?**

увеличение содержания 7 фактора свертывания

растет протромбиновый индекс

повышается фибриноген

снижается фибриноген

снижается скорость свертывания крови

#429

**Какие изменения происходят в железах внутренней секреции при беременности?**

передняя доля гипофиза увеличивается в 2-3 раза

у 35—40% беременных женщин щитовидная железа увеличивается за счет роста числа фолликулов

в задней доле гипофиза накапливаются нейрогормоны окситоцин и вазопрессин

передняя доля гипофиза уменьшается в 2-3 раза

с началом беременности в яичниках начинаются циклические процессы

#430

**Какие изменения происходят в надпочечниках при беременности?**

гипертрофируется пучковая зона коры надпочечников

усиливается синтез кортизола, эстрогенов

усиливается образование глюкокортикоидов

снижается синтез кортизола, эстрогенов

снижается образование глюкокортикоидов

#431

**При нормальной беременности в сердечно-сосудистой системе наблюдаются следующие изменения:**

повышается систолическое давление крови

повышается диастолическое давление крови

снижается периферическое сопротивление сосудов

повышается объем циркулирующей крови

повышается АД

#432

**Какое влияние оказывает прогестерон при беременности?**

способствует накоплению в матке контрактильных белков

защитное действие на оплодотворенную яйцеклетку

снижает тонус матки

способствует росту матки

повышает тонус матки

#433

**Какие из следующих показателей крови являются патологическими для беременности:**

гемоглобин 90г/л

фибриноген 4,9г/л

общий белок 72г/л

тромбоциты  $8 \times 10^9$ /л

СОЭ- 40мм/час

#434

**Какие изменения показателей крови происходят при беременности?**

повышается холестерин

повышается гематокрит

снижается СОЭ

снижается мочеви́на

повышается уровень глюкозы

#435

**При физиологической беременности в дыхательной системе происходят следующие изменения:**

вертикальный размер грудной клетки увеличивается

смещение диафрагмы

увеличение дыхательного объема легких на 30-40%

уменьшение вертикального объема легких

минутный объем дыхания снижается с 8 до 5 л/мин

#436

**Во время беременности обмен веществ в организме матери претерпевает следующие изменения:**

накопление белковых веществ

накопление гликогена в печени, мышечной ткани, плаценте

повышение концентрации холестерина в крови

снижение в крови концентрации липидов, холестерина и нейтрального жира

снижение уровня гликогена в печени, мышечной ткани, плаценте

#437

**Какие изменения происходят в матке к концу беременности?**

объем матки увеличивается в 50 раз

вес матки увеличивается до 500гр

вес матки увеличивается до 1000гр

объем матки увеличивается в 500 раз

длина матки увеличивается до 40 см

#438

**Какие изменения происходят в матке во время беременности?**

объем матки увеличивается в 50 раз

вес матки увеличивается до 500гр

слизистая оболочка трансформируется в децидуальную

связки матки удлиняются и утолщаются

длина матки увеличивается до 40 см

#439

**Какие изменения происходят в шейке матки во время беременности?**

слизистая оболочка шейки становится бледно розовой

шейка размягчается с ранних сроков беременности

слизистая оболочка становится цианотичной

шеечный канал заполнен густой слизью

значительно гипертрофируется

#440

**Как изменяется тонус матки при беременности?**

в 1 триместре снижается тонус матки

нерегулярные слабые сокращения могут наблюдаться всю беременность

к концу беременности повышается сократительная активность

в 1 триместре повышается тонус матки

остается одинаковым на протяжении всей беременности

#441

**Какие изменения происходят в ЦНС во время беременности?**

в 1 триместре снижается возбудимость коры большого мозга

в 1 триместре повышается возбудимость подкорковых центров

в 3 триместре повышается возбудимость коры большого мозга

в 1 триместре повышается возбудимость коры большого мозга  
во 1 триместре снижается возбудимость подкорки и спинного мозга

#442

**Наиболее точно срок беременности можно определить по**

УЗИ, проведенном в третьем триместре  
последней менструации при регулярном МЦ  
УЗИ, проведенном в 10-14 недель  
по уровню ХГЧ  
размерам плода

#443

**С помощью приемов Леопольда-Левицкого можно определить**

массу плода  
позицию плода  
предлежание плода  
отношение предлежащей части ко входу в малый таз  
сердцебиение плода

#444

**Как проводится первый прием Леопольда-Левицкого?**

ладони обеих рук располагаются по бокам от матки  
ладони обеих рук располагаются на дне матки  
концы пальцев рук направлены друг к другу  
пальцы рук не соприкасаются друг с другом  
проводится одной рукой

#445

**С помощью первого приема наружного акушерского исследования определяют:**

предлежание плода

положение, позицию плода

крупную часть плода в дне матки

высоту стояния дна матки

отношение предлежащей части к плоскостям малого таза

#446

**С помощью второго приема наружного акушерского исследования определяют:**

массу плода

положение плода

отношение предлежащей части ко входу в малый таз

позицию плода

размеры головки плода

#447

**Предполагаемую массу плода можно вычислить:**

по формуле Макклюра-Олдрича

умножив высоту стояния дна матки на окружность живота

прибавляя окружность живота к сроку беременности

по формуле Джонса

по формуле Пискачека

#448

**Сократительная функция матки оценивается с помощью:**

наружной гистерографии

внутренней токографии

амниоскопии

радиотелеметрии

пельвиометрии

#449

**К инвазивным методам исследования плода относятся:**

УЗИ

амниоцентез

кордоцентез

аспирация ворсин хориона

непрямое КТГ

#450

**Что представляет собой ромб Михаэлиса?**

это площадка в области лобка

это площадка на задней поверхности крестца

имеет форму правильного ромба с равными сторонами

вертикальная диагональ соответствует истинной конъюгате

вертикальная диагональ соответствует диагональной конъюгате

#451

**Какие утверждения в отношении аускультации сердцебиения плода верны?**

сердцебиение плода может выслушиваться с 18-20 недели

при 1 позиции выслушивается лучше с левой стороны

при головном предлежании выслушивается ниже пупка

при 2 позиции выслушивается лучше с левой стороны

при головном предлежании выслушивается выше пупка

#452

**При оценке КТГ плода имеют значение:**

базальная частота сердечных сокращений

количество шевелений за сеанс

вариабельность

амплитуда схватки

наличие дистракций

#453

**К неинвазивным методам исследования плода относятся:**

амниоцентез

УЗИ

амниоскопия

кордоцентез

непрямое КТГ

#454

**К патологическим типам КТГ относятся:**

акцелерации

базальный ритм ЧСС менее 100

поздние децелерации

выраженные вариабельные децелерации

базальный ритм ЧСС 140

#455

**В задачу влагалищного исследования в родах не входит:**

определение целости плодного пузыря

оценка состояния плода

выяснение степени раскрытия шейки матки

определение особенностей вставления головки

определение срока беременности

#456



**В задачу влагалищного исследования входит:**

определение целости плодного пузыря

оценка состояния плода

выяснение степени раскрытия шейки матки

определение массы плода

характер вставления предлежащей части

#457

**К предположительным признакам беременности относятся:**

прекращение месячных

слюнотечение

тошнота

раздражительность

увеличение размеров матки

#458

**К вероятным признакам беременности относятся:**

Креде Лазаревича

Пискачека

Гентера

Снегирева

Соловьева

#459

**Признак Пискачека**

является достоверным признаком беременности

является вероятным признаком беременности

состоит в появлении куполообразного выпячивания в одном из углов матки

определяется с 7 по 12 неделю беременности

состоит в появлении продольного гребневидного выступа на теле матки

#460

### **Признак Гентера 1**

является достоверным признаком беременности

является вероятным признаком беременности

состоит в появлении продольного гребневидного выступа на теле матки

определяется с 5 по 8 неделю беременности

состоит в появлении куполообразного выпячивания в одном из углов матки

#461

### **Достоверными признаками беременности являются:**

пальпация крупных частей плода

аменорея

наличие хорионического гонадотропина в моче

наличие сердцебиения плода

шевеления плода, определяемое врачом

#462

### **Как меняется размер матки в 1 триместре?**

6 недель размером с гусиное яйцо

в 8 недель размером с гусиное яйцо

12 недель размером с головку новорожденного

5 недель- с мужской кулак

4 недели размером с женский кулак

#463

### **Как можно определить срок беременности**

по формуле Скульского

по формуле Гаусса

по формуле Гентера

по формуле Жордания

по дате последних месячных

#464

**В шкалу Бишопа входит:**

консистенция шейки матки

проходимость шейного канала

положение шейки матки по отношению к оси таза

количество шевелений плода

размеры матки

#465

**Окситоциновый тест во время беременности проводят для:**

определения реактивности миометрия

проверки уровня окситоцина в организме

подтверждения беременности

определения срока беременности

оценки готовности организма к родам

#466

**Какие тесты используются для готовности организма беременной к родам**

кольпоцитологический

маммарный

окситоциновый

прогестероновый

эстрогенный

#467

**Для 1 цитотипа колбоцитологического теста характерно:**

цитоплазма клеток резко базофильна

лейкоциты и слизь отсутствуют

преобладают ладьевидные и промежуточные клетки в соотношении 3:1

эозинофильные клетки составляют 20%

лейкоциты и слизь присутствуют

#468

**Для 2 цитотипа колбоцитологического теста характерно:**

ладьевидные и промежуточные клетки в соотношении 1:1

появляются поверхностные клетки

эозинофильные клетки составляют 2%

эозинофильные клетки составляют 20%

в мазке преобладают клетки промежуточного(60-80%) и поверхностного(25-40%) слоев

#469

**Для 3 цитотипа кольпоцитологического теста характерно:**

в мазке преобладают клетки промежуточного(60-80%) и поверхностного(25-40%) слоев

лейкоциты и слизь присутствуют

эозинофильные клетки составляют 8%

преобладают ладьевидные клетки

лейкоциты и слизь отсутствуют

#470

**Для 4 цитотипа кольпоцитологического теста характерно:**

в мазке преобладают клетки поверхностных (40-80%) слоев

ладьевидные клетки отсутствуют

эозинофильные клетки составляют 20%

в мазке преобладают клетки промежуточного(60-80%) слоя  
цитоплазма клеток резко базофильна

#471

**Изменения в организме женщины к концу беременности:**

повышается уровень прогестерона

повышается уровень эстрогенов

уровень прогестерона и эстрогенов остается неизменным

снижается уровень прогестерона

снижается уровень эстрогенов и повышается уровень прогестерона

#472

**К предвестникам родов относятся следующий признаки**

опускание дна матки

отхождение слизистой пробки

нерегулярные боли

излитие околоплодных вод

регулярные схваткообразные боли

#473

**К концу беременности происходят следующие изменения**

снижение возбудимости головного мозга

повышение синтеза окситоцина

увеличение продукции простагландинов

повышение возбудимости головного мозга

увеличение секреции прогестерона

#474

**Сокращения матки стимулируют**

окситоцин

адреналин

простагландины

преднизолон

прогестерон

#475

**Из каких костей состоит череп новорожденного?**

2 лобные

2 теменные

2 височные

2 затылочные

1 решетчатая

#476

**Какие кости соединяет венечный шов?**

лобные

височные

теменные

затылочную

решетчатую

#477

**Какие кости соединяет ламбдовидный шов?**

затылочную

височные

теменные

лобные

решетчатую

#478

**Какие кости соединяет височный шов?**

звездчатую

лобную

решетчатую

затылочную

теменные

#479

**Поперечные размеры головки плода равны:**

8 см

10,5 см

9,5 см

12 см

11 см

#480

**Точки, между которыми проходит большой косой размер головки плода**

подбородок

переносица

наиболее отдаленный участок на затылке

подзатылочная ямка

подъязычная кость

#481

**Точки, между которыми проходит малый косой размер головки плода**

подзатылочная ямка

наиболее отдаленный участок на затылке

середина переднего родничка

подъязычная кость

подбородок

#482

**Точки, между которыми проходит средний косой размер головки плода**

подзатылочная ямка

наиболее отдаленный участок на затылке

передний угол переднего родничка

подъязычная кость

подбородок

#483

**Точки, между которыми проходит прямой размер головки плода**

переносица

подзатылочная ямка

затылочный бугор

подъязычная кость

сальный родничок

#484

**Точки, между которыми проходит вертикальный размер головки плода**

середина переднего родничка

подбородок

подъязычная кость

малый родничок

подзатылочная ямка

#485



**Какие швы образуют большой родничок:**

лобный

венечный

стреловидный

ламбдовидный

височный

#486

**Какие швы образуют малый родничок**

сагиттальный

лобный

затылочный

височный

венечный

#487

**Второстепенные роднички на головке плода**

клиновидные

венечные

сосцевидные

околоушные

тимпанические

#488

**Какие размеры головки плода имеют размер 9,5см:**

малый косой

вертикальный

большой косой

большой поперечный

малый поперечный

#489

**Для контроля за продвижением головки по родовым путям используют следующие приемы:**

Креде-Лазаревича

четвёртый приём Леопольда-Левицкого

прием Абуладзе

второй приём Леопольда-Левицкого

влагалищное исследование

#490

**Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания включает:**

образование двух точек фиксации

дополнительное сгибание головки

внутренний поворот головки

разгибание головки

наружный поворот головки и внутренний поворот плечиков

#491

**Предлежание плода — это отношение:**

спинки к боковым стенкам матки

спинки к передней стенке матки

наиболее низколежащей части плода ко входу в таз

головки плода ко дну матки

крупной части плода ко входу в малый таз

#492

**К моментам биомеханизма родов при заднем виде затылочного предлежания относятся:**

сгибание головки

дополнительное сгибание головки

образование двух точки фиксации

образование одной точки фиксации

поворот головки на 180 градусов

#493

**Точки фиксации при заднем виде затылочного предлежания:**

середина стреловидного шва

переносица

подзатылочная ямка

подбородок

передний угол большого родничка

#494

**Какие бывают позиции плода?**

спинка кзади- задняя позиция

спинка кпереди- передняя позиция

спинка справа- 2 позиция

спинка слева- 2 позиция

спинка слева- 1 позиция

#495

**Какие бывают виды положения плода?**

спинка слева- 1 вид

спинка справа- 2 вид

спинка кпереди- передний вид

спинка слева- 2 вид

спинка кзади- задний вид

#496

**Что входит в определение членорасположение плода- это**

отношение спинки плода к боковым стенкам матки

отношение предлежащей части ко входу в малый таз

отношение головки к туловищу

отношение спинки плода к передней и задней стенкам матки

отношение мелких частей плода к туловищу

#497

**Названия периодов родов:**

прелиминарный

изгнания

раскрытия

последовый

послеродовый

#498

**Какие фазы различают в течение 1 периода родов**

прелиминарная

латентная

активная

замедления

изгнания

#499

**Чем характерен прелиминарный период?**

длительность не более 6 часов

нерегулярные ноющие боли внизу живота

созревание шейки матки

раскрытие шейки матки более 3 см

продолжительность более 6 часов

#500

**Как можно охарактеризовать контракционное кольцо?**

это граница между сокращающимся верхним и расслабляющимся нижним сегментами

это кольцо между головкой плода и нижним сегментом костями таза

высота его стояния над лоном зависит от степени раскрытия шейки матки

это кольцо между нижним сегментом матки и костями таза

образуется при тугом обвитии пуповины вокруг шеи плода

#501

**С чего начинается и чем заканчивается 1 период родов?**

начинается с регулярных схваток

начинается с излития околоплодных вод

заканчивается полным раскрытием шейки матки

заканчивается рождением плода

заканчивается рождением последа

#502

**С чего начинается и чем заканчивается 2 период родов?**

заканчивается рождением плода

начинается с регулярных схваток

начинается с полного раскрытия шейки матки

заканчивается полным раскрытием шейки матки

заканчивается рождением последа

#503

**С чего начинается и чем заканчивается 3 период родов?**

заканчивается рождением последа

начинается с регулярных схваток

начинается с рождения плода

заканчивается полной инволюцией матки

начинается с полного раскрытия шейки матки

#504

**Продолжительность 2 периода родов составляет**

не более 3 часов у первородящих

не более 1 часа у повторнородящих

не более 2 часов у повторнородящих

не более 2 часов у первородящих

30 мин у повторнородящих

#505

**Ведение 1 периода родов включает:**

обязательное назначение окситоцина

аускультацию плода

влагалищное исследование

мониторинг сократительной активности матки

введение токолитиков

#506

**Как часто производится аускультация плода в 1 периоде родов**

каждый час в латентную фазу

каждые 15 мин

каждые 30 мин в активную фазу

каждые 10 мин

постоянный кардиомониторинг

#507

**Ведение 2 периода родов включает:**

аускультация с/б плода после каждой потуги

мониторинг сократительной активности матки

контроль за продвижением головки

обязательная эпизиотомия

обезболивание

#508

**К родовым изгоняющим силам относятся:**

схватки

контракции

потуги

дистракции

ретракции

#509

**Потуги включают**

сокращения матки

сокращение мышц тазового дна

сокращение диафрагмы

сокращение мышц спины

сокращение мышц ног

#510

**Методы оценки сократительной деятельности матки в родах**

пальпаторный

наружная гистерография

внутренняя гисторография

гравиметрический

индукционный

#511

**Для начала второго периода родов характерно:**

излитие околоплодных вод

раскрытие шейки матки на 8 см

раскрытия шейки матки на 10 см

опускание головки на тазовое дно

началом регулярных схваток

#512

**Попытка выделить не отделившуюся плаценту может привести:**

к ущемлению последа

к кровотечению

к вывороту матки

разрыву промежности

разрыву шейки матки

#513

**Визуальными признаками полного отделения плаценты в родах является:**

изменение контуров и смещение дна матки

удлинение наружного отрезка пуповины

отсутствие втягивания пуповины при глубоком вдохе роженицы

укорочение наружного отрезка пуповины

усиление кровотечения из половых путей

#514



**Послед состоит из**

плаценты

пуповины

амниотической оболочки

децидуальной оболочки

шейки матки

#515

**Признаком полного отделения плаценты в родах будет:**

втяжение отрезка пуповины

изменение контуров и смещение дна матки вправо

втягивание пуповины при глубоком вдохе роженицы

отсутствие пульсации сосудов пуповины

опускание отрезка пуповины

#516

**Регенерация тканей плацентарной площадки происходит под влиянием:**

распада и отторжения остатков амниотической оболочки

регенерации эндометрия из донных желез

эпителизации эндометрия

образования грануляционного вала из тучных клеток

врастания плаценты

#517

**Как можно охарактеризовать врезывание головки**

наблюдается в 1 периоде родов

неправильное вставление головки

наблюдается при тазовом предлежании

наблюдается во 2 периоде родов

во время потуги головка показывается из половой щели, а вне потуги- скрывается

#518

**Как можно охарактеризовать прорезывание головки**

наблюдается в 1 периоде родов

неправильное вставление головки

наблюдается при тазовом предлежании

наблюдается во 2 периоде родов

во время потуги головка показывается из половой щели и не скрывается вне потуги

#519

**Подготовительные схватки отличаются от родовых:**

регулярностью

малоболезненностью

нерегулярностью

различной интенсивностью

сопровождаются раскрытием шейки матки более 4 см

#520

**Окситоцин способствует отделению молока из молочных желез путем:**

сокращения миоэпителиальных клеток в молочных ходах

увеличения секреции пролактина

снижения содержания эстрогенов

снижения содержания андрогенов

снижение гемоглобина

#521

**К препаратам, тормозящим лактацию, относятся:**

достинекс

парлодел

барбитураты

апилак

окситоцин

#522

**Показанием к эпизиотомии в родах является:**

гемолитическая болезнь плода

наложение акушерских щипцов

головное предлежание плода

угроза разрыва ригидной промежности

преждевременные роды

#523

**Ведение родов в первом периоде включает в себя контроль:**

за родовой деятельностью

за особенностями церебральной гемодинамики роженицы

за динамикой раскрытия шейки матки

за сердцебиением плода

за выделениями из носа

#524

**В каких случаях роженице показан постельный режим?**

при доношенной беременности

при Преэклампсии

при головном предлежании

при тазовом предлежании

при невставленной головке

#525

**Что обязательно проводят родильнице с началом родов**

очистительную клизму

катетеризацию кубитальной вены

амниотомию

влагалищное исследование

аускультацию плода

#526

**Показания к амниотомии**

гипоксия плода

рубец на матке

подозрение на разрыв матки

слабость родовых сил

повышенное артериальное давление

#527

**Понятие доношенного плода определяется по:**

состоянию сердечной деятельности плода

росту новорожденного более 45 см

массе новорожденного

признакам физического развития плода

размером стоп плода

#528

**Шкала Апгар включает следующие признаки:**

масса новорожденного

частота сердцебиения

цвет кожных покровов

мышечный тонус

рост новорожденного

#529

**Когда производится оценка новорожденного по шкале Апгар**

на 1 минуте после рождения

в момент рождения

на 5 минуте после рождения

через 10 мин после рождения

через 20 мин после рождения

#530

**Какие из перечисленных признаков являются обязательными для диагностики преэклампсии?**

артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст. на фоне беременности

протеинурия (выделение белка в моче  $\geq 0.3$  г/сутки или  $\geq 300$  mg/24 часа)

головная боль

отеки нижних конечностей

повышение температуры тела

#531

**ХАГ диагностируется**

при повышении АД  $\geq 140/90$  мм рт. ст. до беременности

повышенное АД  $\geq 140/90$  мм рт. ст. сохраняется в течение более 42 дней после родов

при повышении АД  $\geq 140/90$  мм рт. ст. до 20 недель беременности

при первом повышении АД  $\geq 140/90$  мм рт. ст. после 20 недель беременности

при повышении АД  $\geq 130/80$  мм рт. ст. до 20 недель беременности

#532

**Патогенез ПЭ заключается в следующем:**

неполная инвазия ворсин хориона в спиральные артерии

нарушении процессов новообразования сосудов, необходимого для нормальной плацентации

дисфункция эндотелия с дальнейшей системной вазоконстрикцией и тромбообразованием

снижение тонуса периферических артерий

веноспазм

#533

**Тяжелая ПЭ диагностируется, когда**

появляются судороги

повышение температуры тела

появляются отеки на нижних конечностях

артериальное давление выше 160/110 мм рт. ст. на фоне беременности

протеинурия -выделение белка в моче  $\geq 5$  г/сутки

#534

**Какие факторы повышают риск развития преэклампсии у беременной женщины?**

первая беременность (первобеременность)

многоплодная беременность

возраст старше 35 лет или младше 18 лет

регулярное выполнение физических упражнений

нормальный индекс массы тела до беременности

#535

**Какие осложнения могут возникнуть при преэклампсии?**

эклампсия (судороги)

отслойка плаценты

церебральный инсульт

сахарный диабет

бронхиальная астма

#536

**Приступ эклампсии может развиваться**

в 40 недель беременности

в родах

в послеродовом периоде

в 10 недель беременности

в 18 недель беременности

#537

**Какие препараты могут использоваться для лечения артериальной гипертензии при преэклампсии?**

лабеталол

нифедипин

метилдопа

лизиноприл

эналаприл

#538

**HELLP-синдром включает**

гемолиз

тромбоцитопения

повышение уровня АЛТ и АСТ

судороги

отек легких

#539

**Особенности ведения родов при тяжелой преэклампсии**

мониторинг АД

обезболивание с применением перидуральной анестезии

в/в инфузия магния сульфата

обязательно родоразрешение путем Кесарева сечения

в/в инфузия окситоцина

#540

**Какие препараты используются для противосудорожной терапии при ПЭ?**

магния сульфат

тиопентал натрий при неэффективности магнезии

примидон

фенобарбитал

клоназепам

#541

**Какие из перечисленных факторов могут быть причинами преждевременных родов?**

многоплодная беременность

наличие инфекционных заболеваний у матери

стрессы и физическое переутомление

нерегулярное посещение врача-гинеколога

неправильное питание

#542

**Какие осложнения могут возникнуть у ребенка, рожденного преждевременно?**

респираторный дистресс-синдром

внутрижелудочковые кровоизлияния

неонатальная желтуха

сахарный диабет

бронхиальная астма



#543

**Какие изменения можно выявить при УЗИ у пациентки с угрозой преждевременных родов?**

укорочение шейки матки менее 25 мм

раскрытие внутреннего зева шейки матки

раннее старение плаценты

увеличение размеров плода

снижение объема околоплодных вод

#544

**В какие сроки показано назначение кортикостероидов при угрозе преждевременных родов?**

срок беременности 24–28 недель

срок беременности 29–34 недели

низкое артериальное давление

срок беременности более 37 недель

наличие сахарного диабета у матери

#545

**Какие препараты могут использоваться для лечения угрозы преждевременных родов?**

блокаторы кальциевых каналов (Нифедипин)

кортикостероиды для ускорения созревания легких плода

гестагены

противосудорожные препараты (например, магнезия)

гормональные контрацептивы

#546

**В каких случаях показано назначение прогестерона для профилактики преждевременных родов?**

короткая шейка матки (менее 25 мм)

наличие в анамнезе преждевременных родов

отсутствие противопоказаний к его применению

срок беременности более 37 недель

многоплодная беременность

#547

**Методы коррекции истмико-цервикальной недостаточности**

хирургический- наложение шва на шейку матки

применение акушерского пессария

в/в инфузия токолитика

назначение антиоксидантов

озонотерапия

#548

**Какие из перечисленных средств применяются для преиндукции родов?**

мифепристон

динопростон

дилапан

прогестерон

бетаметазон

#549

**Какие из перечисленных признаков указывают на наличие многоводия?**

амниотомия

в/в инфузия окситоцина

в/в инфузия дротаверина

миролют сублингвально

дексаметазон в/м

#550

### **Признаки перезрелости плода:**

цианоз

обилие сыровидной смазки на теле

банные стопы и ладони

желто-зеленое окрашивание кожи

узкие швы и роднички

#551

### **УЗ критерии переношенной беременности**

увеличение толщины плаценты

увеличение объема околоплодных вод

зазубренность краев хориальной пластины

уменьшение толщины плаценты

уменьшение объема околоплодных вод

#552

### **Для диагностики переношенной беременности используют**

УЗИ

амниоскопию

кордоцентез

амниоцентез

биопсию плаценты плаценты

#553

### **Хронологическое перенашивание характеризуется следующими признаками**

рождается переносенный ребенок

на УЗИ плаценты истончена с кальцинатами

плацента без признаков старения

рождается доношенный ребенок

длится более 294 дней

#554

**Какие из перечисленных признаков указывают на наличие многоводия?**

увеличение окружности живота

затруднение пальпации частей плода

брадикардия у плода

снижение массы тела беременной

уменьшение объема околоплодных вод

#555

**Какие основные причины развития многоводия?**

сахарный диабет матери

аномалии развития плода

анемия

преэклампсия

ожирение

#556

**Какие осложнения могут возникнуть у матери при многоводии?**

преждевременные роды

послеродовое кровотечение

преждевременная отслойка плаценты

снижение уровня гемоглобина до нормальных значений

повышение артериального давления

#557

**Какие методы исследования используются для подтверждения многоводия?**

УЗИ с оценкой индекса амниотической жидкости (ИАЖ)

Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки

положительный симптом флюктуации при пальпации

кардиотокография (КТГ)

общий анализ крови

#558

**Какие особенности характерны для ведения родов при многоводии?**

высокий риск выпадения петель пуповины

необходимость медленного излития околоплодных вод

повышенный риск послеродового кровотечения

контроль артериального давления и пульса

немедленное кесарево сечение без показаний

#559

**В каких случаях показано кесарево сечение при многоплодной беременности?**

неправильное предлежание первого плода

синдром фето-фетальной трансфузии

тройня

головное предлежание обоих плодов

наличие отеков на нижних конечностях

#560

**Какие осложнения могут возникнуть у матери при многоплодной беременности?**

анемия

преэклампсия

преждевременные роды

снижение уровня глюкозы в крови

уменьшение окружности живота

#561

**Какие осложнения могут возникнуть у беременной с сахарным диабетом?**

макросомия плода

преэклампсия

снижение уровня глюкозы в крови

уменьшение массы тела беременной

улучшение функции поджелудочной железы

#562

**Какие осложнения могут возникнуть у беременной с хронической почечной недостаточностью?**

задержка внутриутробного роста плода

преэклампсия

улучшение функции почек

снижение уровня креатинина в крови

увеличение объема околоплодных вод

#563

**Какие последствия может вызвать анемия у беременной?**

гипоксия плода

повышение риска послеродового кровотечения

улучшение состояния плода

снижение уровня околоплодных вод

увеличение массы тела беременной

#564

**Какие факторы повышают риск развития пиелонефрита у беременной?**

наличие хронического пиелонефрита в анамнезе

снижение иммунитета

наличие инфекций мочевыводящих путей (ИМВП)

антибактериальная терапия в анамнезе

отягощенный акушерский анамнез

#565

**Какие методы исследования используются для диагностики пиелонефрита у беременной?**

общий анализ мочи

бактериологическое исследование мочи (посев)

УЗИ почек и мочевыводящих путей

измерение окружности живота

определение уровня глюкозы в крови

#566

**Классификация узкого таза по форме включает следующие виды**

Гинекоидный

Антропoidный

Андроидный

Готической

Идиопатический

#567

**Часто встречающиеся формы узкого таза**

общеравномерносуженный

плоский таз

поперечносуженный

кососмещенный

ассимиляционный

#568

**Клинически узкий таз можно заподозрить**

при затяжном течении родов

при отеке шейки матки

наличии потуг при высоко стоящей головке

низком росте роженицы

ригидной промежности

#569

**Диагноз клинически узкого таза устанавливают**

в родах

на основании признаков диспропорции предлежащей части плода и таза матери

при полном раскрытии шейки матки

во время беременности

на основании размеров головки

#570

**Для клинически узкого таза характерно**

положительный признак Боделока

отрицательный признак Цангмейстера

симптом раздражения брюшины

положительный признак Вастена

положительный признак Цангмейстера

#571

**Показания к операции Кесарево сечение при узком тазе**

крупный плод

рубец на матке

тазовое предлежание плода

мертвый плод

головное предлежание плода



#572

**Осложнения в течение родов при узком тазе:**

раннее излитие околоплодных вод

травматизм плода

затяжное течение

стремительные роды

отслойка плаценты

#573

**Какие размеры характерны для узкого таза**

28\*29\*31\*18 см

23\*25\*28\*21 см

26\*29\*31\*18 см

26\*29\*31\*21 см

25\*28\*30\*20 см

#574

**Виды аномалий родовой деятельности**

диссоциированная родовая деятельность

диспропорциональная родовая деятельность

слабость родовой деятельности

дискоординированная родовая деятельность

патологический прелиминарный период

#575

**Слабость родовых сил - это:**

общая продолжительность родов 14 часов у первобеременной

раскрытие шейки матки менее 1 см/ч

регулярные схватки через 3 - 5 минут

продолжительность II периода родов < 2 часов

продвижение головки во 2 периоде со скоростью менее 1 см/ч

#576

**При какой аномалии родовой деятельности нецелесообразно назначение окситоцина?**

при чрезмерной родовой деятельности

при дискоординированной родовой деятельности

при первичной слабости родовых сил

при слабости потуг

при слабости родовой деятельности в 1 периоде родов

#577

**Какие схватки типичны для слабости родовой деятельности?**

сильные и короткие

сильные и длительные

сильные и нерегулярные

слабые и короткие

слабые и редкие

#578

**Для лечения слабости родовой деятельности применяют:**

токолитики

амниотомия

спазмолитики

окситоцин

промедол

#579

## **Виды дискоординированной родовой деятельности**

диссоциированная родовая деятельность

диспропорциональная родовая деятельность

дискоординация схваток

тетания матки

дистоция шейки матки

#580

### **Стимуляция родовой деятельности показана при:**

вторичной слабости родовых сил

дискоординированной родовой деятельности

патологическом прелиминарном периоде

гипоксии плода

первичной слабости родовой деятельности

#581

### **Лечение первичной слабости родовой деятельности включает:**

в/в капельное введение утеротоников

амниотомию

обезболивание

медикаментозный сон

сульфат магния

#582

### **Для лечения дискоординации родовой деятельности применяют:**

окситоцин

простенон

простагландины

токолитики

гинепрал

#583

**Для лечения тетании матки применяют**

окситоцин в/в

нитроглицерин сублингвально

эпидуральная анестезия

гексапреналин

простагландины в/в

#584

**При расположении головки плода на тазовом дне и острой гипоксии плода врач должен:**

выполнить кесарево сечение

произвести эпизиотомию

наложить акушерские щипцы

назначить спазмолитики

начать лечение внутриутробной гипоксии плода

#585

**Причины тазового предлежания плода:**

первая беременность

узкий таз

многоводие

предлежание плаценты

преэклампсия

#586

**Причины тазового предлежания плода:**

переношенность

недоношенность

миома матки

аномалии развития матки

преэклампсия

#587

**Показания к Кесареву сечению при тазовом предлежании плода**

узкий таз

ягодичное предлежание

масса плода 3500

мужской пол плода баллотирующая часть

рубец на матке

#588

**Виды тазового предлежания:**

копчиковое

коленное

ягодично-ножное

ножное

крестцовое

#589

**Какие пособия используются при приеме родов в тазовом предлежании?**

Гентера

Цовьянова-1

Морисо-Левре-Лашапель

классическое ручное пособие

Абуладзе

#590

**Можно ли произвести наружный поворот плода на головку при тазовом предлежании**

можно во время беременности при сроке 36-37 недель

нельзя

можно произвести в родах у 1 плода из двойни

можно произвести в 1 периоде при одноплодной беременности

можно произвести во 2 периоде поворот второго плода из двойни после рождения 1 плода

#591

**Противопоказания к наружному повороту плода на головку при тазовом предлежании**

одноплодная беременность

патологическое КТГ

многоплодие

аномалии матки

у многорожавшей

#592

**Цель пособия по Цовьянову I**

предупреждение выпадения пуповины

сохранение физиологического членорасположения плода

предупреждение запрокидывание ручек

предупреждение разгибание головки плода

профилактика гипоксии плода

#593

**Цель пособия по Цовьянову II**

перевести ножное предлежание в смешанное

сохранение физиологического членорасположения плода

предупреждение слабости потуг

предупреждение гипоксии плода

увеличение объема предлежащей части плода и достижению полного раскрытия маточного зева

#594

**Какое осложнение встречается чаще всего при поперечном положении плода:**

преждевременное или раннее отхождение вод, выпадение ручки

слабость родовой деятельности

кровотечение

выпадение пуповины

образование мочеполовых свищей

#595

**Причины поперечного положения плода**

узкий таз

предлежание плаценты

высокий рост беременной

первая беременность

экстрагенитальная патология

#596

**При запущенном поперечном положении плода показано:**

кесарево сечение

наружный поворот плода

мероприятия, направленные на сохранение беременности

родовозбуждение с последующим наружно-внутренним поворотом плода

антибактериальная терапия в послеоперационном периоде

#597

**При каком положении плода при влагалищном исследовании прощупывают подмышечную впадину, иногда локти или кисть:**

при продольном

при поперечном

при косом

при 1-й позиции продольного положения плода

при заднем виде

#598

**К разгибательным предлежаниям головки относят все, кроме:**

переднеголовное

лицевое

лобное

затылочное

задний вид затылочного

#599

**К особенностям биомеханизма родов при разгибательных вставлениях головки относятся:**

роды протекают в переднем виде

в первом моменте происходит сгибание головки

внутренний поворот головки происходит в плоскости выхода из малого таза

в первом моменте происходит разгибание головки

роды протекают в заднем виде

#600

**Этиология разгибательных предлежании не включает:**

узкий таз (анатомически и клинически)

снижение тонуса и некоординированные сокращения матки

врожденные опухоли щитовидной железы плода



наличие брюшного пресса

соответствие размеров головки и таза

#601

**Точки фиксации при переднеголовном предлежании:**

надпереносье

затылочный бугор

подзатылочная ямка

граница волосистой части головы, подзатылочная ямка

область подъязычной кости

#602

**Точки фиксации при лобном предлежании:**

верхняя челюсть

затылочный бугор

подзатылочная ямка

граница волосистой части лба, подзатылочная ямка

большой родничок

#603

**Какие осложнения родов встречаются при разгибательных вставлениях головки**

стремительные роды

отслойка плаценты

травматизм матери

травматизм плода

клинически узкий таз

#604

**Какие из перечисленных симптомов не типичны для послеродового эндометрита**

повышение АД

озноб

тахикардия

нормальная температура тела

боли внизу живота с иррадиацией в поясницу

#605

**Наиболее частый путь распространения инфекции при мастите:**

лимфогенный

гематогенный

галактогенный

восходящий

воздушно-капельный

#606

**Что из перечисленного не является причиной акушерского перитонита**

хориоамнионит

преэклампсия в родах

несостоятельность швов на матке

аномалии развития матки

восходящая инфекция

#607

**Клиническая картина послеродового эндометрита включает:**

симптомы интоксикации

субинволюцию матки

мягкую консистенцию и болезненность матки при пальпации

отсутствие болевого синдрома

гиперемию в области лобка

#608

**Диагностика гипотрофии плода:**

УЗИ плода

КТГ плода

доплерометрия плода

взвешивание беременной

клинический анализ крови

#609

**Плацентарная недостаточность может быть:**

острая

хроническая

компенсированная

замедленная

бессимптомная

#610

**Назовите основные формы задержки роста плода:**

ранняя

поздняя

острая

хроническая

неполная

#611

**Клинические методы диагностики хронической плацентарной недостаточности:**

измерение окружности живота и высоты стояния дна матки

аускультация плода

сбор анамнеза

измерения размеров таза

определение индекса массы тела плода

#612

**Кардиотокографические признаки гипоксии плода:**

базальный ритм более 160 уд в 1 минуту или менее 120 уд в 1 минуту

наличие выраженных децелераций

отрицательный нестрессовый тест

нормальный нестрессовый тест

базальный ритм 120-160 ударов в 1 минуту

#613

**Для ранней формы гипотрофии плода характерно:**

равномерное уменьшение размеров плода

развитие в ранние сроки беременности

большая масса

предлежание плаценты

развивается только в 3-ем триместре беременности

#614

**Для поздней формы гипотрофии плода характерно:**

уменьшение только окружности головы и живота при нормальном росте

размеры трубчатых костей соответствует сроку, а размеры головы и живота уменьшены

увеличены все размеры плода

уменьшение всех размеров

уменьшение только размеров головы

#615

**Лечение плацентарной недостаточности должно быть направлено на:**

улучшение маточно- плацентарно- плодового кровотока

улучшение метаболических и обменных процессов плода, устранение гиповолемии и гипопроотеинемии

усиление антиоксидантной защиты

усиление сократительной способности матки

гипотензивная терапия

#616

**Виды гипоксий плода:**

гипоксическая гипоксия плода

циркуляторная гипоксия

гемическая гипоксия

интервальная

затяжная

#617

**Причины гипоксии плода:**

недостаточная перфузия материнской поверхности

нарушение гемодинамики в пуповине

осложнения беременности

зуд беременных

тазовое предлежание плода

#618

**Для острой гипоксии плода характерно:**

сердцебиение плода ниже 110 уд в 1 мин

глухость сердечных тонов

аритмия

сердцебиение плода выше 140 ударов в 1 минуту

сердцебиение плода 130-150 уд в 1 мин

#619

**Критерии диагностики тяжелой асфиксии:**

оценка по шкале Апгар в конце первой минуты жизни 3 балла и ниже

глубокий метаболический или смешанный ацидоз

клинические признаки полиорганной недостаточности

незначительный периоральный цианоз

понижение фетального гемоглобина

#620

**Какие утверждения верны в отношении резус-конфликта матери и плода**

чаще развивается при повторных беременностях

возможен у резус-отрицательной матери и рез-положительном плоде

чаще развивается при первой беременности

развивается у резус-отрицательной матери с резус положительным плодом

развивается при наличии положительного резуса у матери и отрицательного резуса у отца

#621

**Какие данные из анамнеза являются факторами риска развития резус-конфликта?**

гемотрансфузия в прошлом

кровотечения во время беременности

инвазивные диагностические и лечебные вмешательства

курение

ношение бандажа при беременности

#622

**О крайне тяжелом течении ГБП свидетельствуют следующие данные УЗИ**

развитие асцита плода

гидроторакс плода

гидроперикард плода

гепатомегалия

толщина плаценты более 5 см

#623

**Профилактика резус-сенсibilизации беременных заключается**

в введении антирезус-иммуноглобулина в 28 недель беременности

в введении антирезус-иммуноглобулина в первые 72 часа после родов

в введении антирезус-иммуноглобулина в 12 недель беременности

в введении антирезус-иммуноглобулина в 32 недели беременности

в введении антирезус-иммуноглобулина в 38 недель беременности

#624

**С целью своевременной диагностики следует направлять беременную с резусотрицательной принадлежностью крови на определение антиэритроцитарных (антирезусных) антител**

при первом визите

18-20 недель

28 недель

38 недель

после родов

#625

**Формы ГБП по тяжести анемии и наличию водянки плода:**

умеренная анемия

тяжелая анемия

тяжелая анемия с водянкой плода

асцитическая

гепатомегалическая

#626

**Критерии развившегося резус-конфликта и гемолитической болезни плода**

асцит у плода

определение зоны «С» при проведении доплерометрии в средне-мозговой артерии плода

определение зоны «А» при проведении доплерометрии в средне-мозговой артерии плода

гепатомегалия у матери

гепатомегалия у плода

#627

**Для лечения ГБП рекомендуется**

десенсебилизирующая терапия

плазмаферез

внутриутробное внутрисосудистое переливание ЭМОЛТ плоду

гемосорбция

родоразрешение

#628

**Причинами преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты могут быть:**

травма живота

быстрое опорожнение при многоводии

патологические изменения в сосудах плаценты при преэклампсии

воспалительные процессы матки и придатков

истмико-цервикальная недостаточность

#629

**Факторы, предрасполагающие к развитию предлежания плаценты**

дистрофические изменения эндометрия



рубец на матке

миома матки

узкий таз

анемия

#630

**Преждевременная отслойка плаценты- это отслойка плаценты**

в 25 недель беременности

в 1 периоде родов

во 2 периоде родов

в 3 периоде родов

в 6 недель беременности

#631

**От чего зависит выбор акушерской тактики при ПОНРП**

срока беременности

состояния плода

объема кровопотери

паритета родов

возраста пациентки

#632

**Консервативная тактика ведения при ПОНРП предполагает**

снижение тонуса миометрия

коррекция гемостаза

профилактика респираторного дистресса плода

назначение утеротоников

наложение шва на шейку матки

#633

**Признаки ПОНРП:**

гипертонус матки

боль

гипоксия плода

гипотония матки

гипертермия

#634

**Истинное вращение плаценты требует:**

тщательное отделение плаценты от стенок матки рукой

тщательное удаление плаценты из матки кюреткой

эмболизация сосудов матки

чревосечение и удаление матки

органосохраняющая гистеропластика

#635

**Причины ранних послеродовых кровотечений**

гипотония матки

задержка частей последа в полости матки

коагулопатия

послеродовая инфекция

маловодие

#636

**Показанием для ручного обследования послеродовой матки являются:**

кровопотеря 500 мл

задержка в матке доли плаценты

подозрение на разрыв матки

при кровопотере 250 мл

при подозрении на разрывы мягких тканей влагалища

#637

**Какие мероприятия из перечисленных используют для остановки послеродового кровотечения:**

окситоцин внутривенно

балонная тампонада

наружный массаж матки

зондирование полости матки

бетта-адреномиметики в/в

#638

**Клинические признаки, характерные для предлежания плаценты:**

повторяемость кровянистых выделений

безболезненность

нормотонус матки

болезненность

повышенный тонус матки

#639

**Причины кровотечения в послеродовом периоде:**

разрывы мягких родовых путей

гипотония матки

задержка частей плаценты в полости матки

расхождение лонного сочленения

использования эпидуральной анестезии в родах

#640

**Стадии геморрагического шока**

компенсированный шок

декомпенсированный обратимый шок

декомпенсированный необратимый шок

рефрактерный шок

терминальный шок

#641

**1 стадия геморрагического шока характеризуется**

объем кровопотери составляет 20% ОЦК

бледность кожных покровов

тахикардия до 100 уд/мин

тахикардия 120-140/мин

гипотония ниже 90/70 мм рт ст

#642

**2 стадия геморрагического шока характеризуется**

объем кровопотери составляет 25-40% ОЦК

АД ниже 100 мм рт ст

тахикардия до 120-130 уд/мин

спутанность сознания

гипотония ниже 70 мм рт ст

#643

**3 стадия геморрагического шока характеризуется**

объем кровопотери составляет 40-60% ОЦК

АД ниже 60 мм рт ст

тахикардия 140-160 уд/мин

тахикардия 110-120/мин

гипотония ниже 90/70 мм рт ст

#644

**Об адекватности гемодинамики при геморрагическом шоке судят по**

цвету и температуре кожных покровов

величине АД

шоковому индексу

уровню фибриногена

уровню креатинина

#645

**К причинам разрыва промежности относятся**

ригидная промежность

стремительные роды

крупный плод

применения эпидуральной анестезии в родах

чаще у многорожавших

#646

**Классификация разрыва матки по локализации**

в дне

в нижнем сегменте

отрыв матки от сводов

в шейке матки

по задней стенке матки

#647

**Классификация разрыва матки по этиопатогенезу включает**

механический

гистопатический

смешанный

частичный

полный

#648

**Для клинической картины разрыва шейки матки характерно**

периодически повторяющееся кровотечение из половых путей

гипотония матки

постоянное кровотечение при хорошо сократившейся плотной матке

выраженный болевой синдром

отсутствие болевого синдрома

#649

**Причины разрыва матки во время беременности**

клинически узкий таз

анатомически узкий таз

рубец, расположенный в теле матки

несостоятельность рубца на матке

рубец, расположенный в дне матки

#650

**Симптомами угрожающего разрыва матки являются:**

кровотечение

высокое стояние контракционного кольца, форма матки в виде песочных часов

болезненность нижнего сегмента матки при пальпации

потуги при высоко стоящей головке плода

гипертермия

#651

**При угрожающем механическом разрыве матки наблюдается**

бурная родовая деятельность

матка в форме «песочных часов»

выраженная болезненность схваток

состояние шока

ослабление родовой деятельности

#652

**Клинические признаки совершившегося разрыва матки**

кинжальная боль в животе

тяжелое состояние женщины, связанное с шоком

прекращение родовой деятельности

гипертонус матки

тахикардия плода

#653

**При расхождении в родах лонного сочленения рекомендовано**

постельный режим

физиотерапия в целях ускорения репарации

препараты кальция

не требует лечения

отказ от грудного вскармливания

#654

**При разрыве промежности 2 ст. происходит:**

разрыв стенки прямой кишки

повреждение мышц промежности

разрыва сфинктера прямой кишки

повреждения кожи промежности

повреждения слизистой влагалища

#655

**При разрыве промежности 1ст. швы накладывают на:**

на слизистую влагалища

на кожу промежности

на мышцы промежности

заднюю спайку

слизистую шейки матки

#656

**Чего не происходит при разрыве промежности 1 степени?**

нарушения задней спайки

повреждения стенок влагалища

повреждения мышц промежности

повреждения наружного сфинктера прямой кишки

повреждения кожи промежности

#657

**Принципы лечения совершившегося разрыва матки:**

адекватное анестезиологическое пособие

лапаротомия

гистерэктомия

внутривенная инфузия бета-адреноблокаторов

внутривенная инфузия утеротоников

#658

**Признаки угрожающего разрыва матки**

кровянистые выделения из половых путей



прекращение родовой деятельности

матка в форме «песочных часов»

выраженная болезненность схваток

гипоксия плода

#659

#### **Причины разрыва промежности**

крупный плод

стремительные роды

неправильное оказание акушерского пособия в родах

слабость потуг

дистоция шейки матки

#660

#### **Возникновению разрывов промежности в родах способствует**

прорезывание головки плода неблагоприятным размером

наложение акушерских щипцов

крупный плод

недоношенность

высокий рост роженицы

#661

#### **Показания к эпизиотомии**

угроза разрыва промежности

операция наложения акушерских щипцов

крупный плод

дистресс плода

роды с рубцом на матке

#662

**Какие ткани повреждаются при разрыве промежности 2 степени?**

мышцы промежности

сфинктер прямой кишки

задняя стенка влагалища

кожа промежности

слизистая прямой кишки

#663

**При разрыве промежности II степени проводят, как правило, поэтапное зашивание**

слизистой влагалища

мышц промежности

кожи промежности

наружного сфинктера прямой кишки

слизистой прямой кишки

#664

**Профилактика разрывов промежности включает**

правильное оказание акушерского пособия

правильное ведение родов

своевременную эпизиотомию

использование утеротоников

раннюю амниотомию

#665

**Какие методы анестезии возможны при проведении операции К/сечение?**

в/в седация

инфильтрационная анестезия

эпидуральная анестезия

спинальная анестезия

эндотрахеальный наркоз

#666

**Противопоказания со стороны пациентки к проведению нейроаксиальной анестезии:**

тяжелая миопия

тяжелая преэклампсия

выраженная гиповолемия

отказ пациентки

гнойные образования в месте пункции

#667

**Какие лабораторные исследования являются обязательными перед операцией К/сечение?**

определение антигена (ДНК) стрептококка группы В (*S.agalactiae*) из зева методом ПЦР

анализ на наследственные тромбофилии

биохимический анализ крови

определение антигена (ДНК) стрептококка группы В (*S.agalactiae*) в отделяемом цервикального канала методом ПЦР

коагулограмма

#668

**Какие виды разреза брюшной стенки применяют для кесарева сечения?**

параректальный

от пупка до мечевидного отростка

По Пфанненштилю

По Джоэль-Кохену

по Гусакову

#669

**Какие из нижеперечисленных показаний к операции «Кесарева сечения» относятся к абсолютным**

узкий таз 3-4 степени

центральное предлежание плаценты

слабость родовых сил

хроническая гипоксия плода

тазовое предлежание плода

#670

**Какие из нижеперечисленных показаний к операции «Кесарева сечения» относятся к абсолютным**

врастание плаценты

несостоятельный рубец на матке

слабость родовых сил

многоводие

тазовое предлежание плода

#671

**Какие из нижеперечисленных показаний к операции «Кесарева сечения» относятся к абсолютным**

масса плода более 4500gr

устойчивое поперечное положение плода при доношенном сроке

тазовое предлежание

резус-сенсibilизация

многоплодие

#672

**Какие из нижеперечисленных показаний к операции «Кесарева сечения» считаются относительными?**

абсолютно узкий таз

угрожающий разрыв матки

рак шейки матки

узкий таз 1 степени

тазовое предлежание плода

#673

**Перед родоразрешением путем КС рекомендовано**

удаление волос в области предполагаемого разреза

пальпация для уточнения положения и предлежания плода

выслушивание с/б плода

очистительная клизма за 30 мин до операции

консультация кардиолога

#674

**Что является противопоказанием для производства Кесарева сечения, если оно делается не по жизненным показаниям?**

гнойные выделения из родовых путей

боли в нижней части живота

кровотечение из половых путей

возраст беременной 17 лет

внутриутробная гибель плода

#675

**Преимущество поперечного разреза нижнего маточного сегмента при Кесаревом сечении заключается:**

в уменьшении травматизма плода

в уменьшении травматизма матери

в уменьшении частоты послеоперационных осложнений

в уменьшении кровопотери

легче добиться перитонизации

#676

**Признаком несостоятельности рубца на матке считается**

толщина рубца менее 3 мм

интервал между беременностями 2 года

расположение плаценты на рубце

размеры плода 3400гр

корпоральный рубец

#677

**Профилактика тромбоэмболических осложнений при проведении операции «Кесарево сечение» включает**

использование компрессионного трикотажа

введение гепарина за 30 минут до операции

ранняя мобилизация

назначение НМГ через 24 часа после операции

постельный режим 24 часа после операции

#678

**В каких случаях производят корпоральный разрез на матке при Кесаревом сечении**

выраженный варикоз вен в области нижнего сегмента матки

наличие корпорального рубца после предыдущей операции

при проведении операции на умершей или агонирующей роженице

при наличии узкого таза 3 степени

при ПОНРП

#679

**Как извлекается плод при проведении Кесарева сечения**

за головку при головном предлежании

за ножку при тазовом предлежании

за ножку при поперечном положении

за головку при ножном предлежании

за ножку при головном предлежании

#680

**Ведение родильниц в послеоперационном периоде (после К/сечения) включает**

ранняя активация (через 4-6ч)

обезболивание

выписка на 5 сутки

выписка на 7-10 сутки

постельный режим в течение 24 ч

#681

**Преимущества нейроаксиальных методов анестезии перед эндотрахеальным наркозом:**

отсутствие негативного влияния на плод

меньшее количество осложнений

возможность энтерального питания в первые же часы после операции

не вызывает гипотензию

не вызывает боли в послеоперационном периоде

#682

**Ведение родов с рубцом на матке включает**

постоянный кардиомониторинг плода

проведение УЗИ в раннем послеродовом периоде для исключения разрыва матки

ведение родов при условии развернутой операционной

применение эпидуральной анестезии

назначение антибиотиков в послеродовом периоде

#683

**Какие утверждения в отношении оперативного родоразрешения верны?**

при головке, расположенной в широкой части полости малого таза показано родоразрешение путем операции кесарева сечения

при головке, расположенной в выходе – предпочтительно родоразрешение с помощью вакуум-экстракции

при головке, расположенной в узкой части предпочтительно родоразрешение с помощью акушерских щипцов

при головке, расположенной в выходе – предпочтительно родоразрешение с помощью акушерских щипцов

при головке, расположенной в широкой части полости малого таза показано родоразрешение путем вакуум-экстракции

#684

**Подготовка к операции наложения выходных акушерских щипцов состоит:**

в опорожнении мочевого пузыря

в создании условий асептики

в проведении тщательного влагалищного исследования

в предварительной инфузии токолитиков

в проведении КТГ

#685

**Что включает третье тройное правило наложения АЩ?**

при головке, расположенной в широкой части таза, тракции направлены на ноги, на себя и вверх

при головке, расположенной в узкой части таза, тракции направлены на себя и вверх

при головке, расположенной в выходе таза, тракции направлены вверх

при головке, расположенной в узкой части таза, тракции направлены на ноги, на себя и вверх

при головке, расположенной в выходе таза, тракции направлены на себя и вверх



#686

**Что включает второе тройное правило наложения АЩ?**

введенные ложки должны быть направлены вверх

ложки должны лежать бипариетально

проводная точка и ось головки лежит в плоскости замковой части щипцов

введенные ложки должны быть направлены вниз

ложки должны лежать в вертикальной плоскости

#687

**Рекомендовано врачу перед оперативным влагалищным родоразрешением у всех рожениц**

произвести аускультацию плода с целью оценки его состояния

произвести влагалищное исследование для выяснения акушерской ситуации

опорожнить мочевой пузырь

взять мазок на бета-гемолитический стрептококк

провести общий анализ крови

#688

**Показания для наложения акушерских щипцов**

острая гипоксия плода во 2 периоде

эклампсия во 2 периоде родов

ПОНРП в 1 периоде родов

слабость потуг

кровотечение в 3 периоде

#689

**Условия для наложения акушерских щипцов**

полное раскрытие шейки матки

раскрытие 8 см

отсутствие плодного пузыря

живой плод

мертвый плод

#690

**Какое обезболивание требуется при наложении акушерских щипцов?**

не требуется

инфильтрационная анестезия

в/в пропафол

в/в тиопентал натрия

спинальная анестезия

#691

**Рекомендовано врачу перед оперативным влагалищным родоразрешением у всех рожениц произвести**

профилактику респираторного дистресс-синдрома плода

аускультацию плода

влагалищное исследование

информировать роженицу о предстоящей операции

ввести токолитики

#692

**Противопоказаниями к влагалищному оперативному родоразрешению являются:**

анатомическое сужение таза 2-3 ст и клинически узкий таз

тазовое, лобное предлежание

положение головки выше широкой части

живой плод

наличие инфекции в родовых путях

#693

### **Техника операции вакуум-экстракции плода**

чашечка ВЭ устанавливается на проводную точку таким образом, что стреловидный шов делит ее пополам

расстояние между краем чашечки ВЭ и задним краем большого родничка должно составлять около 3 см

чашечка ВЭ устанавливается в области большого родничка

анестезия перед проведением операции (спинальная или пудендальная)

тракция плода производится непрерывно до рождения головки плода